



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Enfermería

Nivel de conocimientos sobre Lactancia Materna Exclusiva en madres que acuden a un Centro de Salud, Lima – 2024

TESIS

Para optar al Título Profesional de Licenciada en Enfermería

AUTOR

Sol Venus RODRIGUEZ VELA

ASESOR

Dra. Nancy HUAMAN SALAZAR

Lima, Perú

2024

RESUMEN

Introducción: La lactancia materna exclusiva es una práctica muy antigua que ha ido perdiendo relevancia en los últimos años, generando un riesgo en la salud del niño menor de 6 meses; sin embargo, los profesionales de la salud pueden fomentarla mediante la educación, para que las madres lo realicen de manera consciente.

Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres que acuden al Centro de Salud Zárate en Lima, 2024.

Métodos: Estudio tipo cuantitativo, método descriptivo, de nivel aplicativo y de corte transversal. La muestra de 162 madres, la técnica encuesta y el instrumento un cuestionario validado por jueces expertos, cuyo Coeficiente de Validez de Contenido (CVCtc) de 0,88, que según Hernández – Nieto es bueno.

Resultados: El nivel de conocimientos de las madres sobre lactancia materna exclusiva fue medio con 56,1% (64), así como en las dimensiones aspectos generales y técnica de amamantamiento obtuvieron 51% (58) y 54% (62), respectivamente.

Conclusiones: Las madres presentaron un nivel de conocimiento medio de forma general y en ambas dimensiones respecto a la lactancia materna exclusiva, revelando que existe poca adherencia al recibir la información; lo que implica que los niños y niñas en los primeros 6 meses de vida no gozarían de todos los beneficios que brinda la leche materna a corto y a largo plazo.

Palabras clave: Conocimiento, lactancia materna exclusiva, madre, lactante.

ABSTRACT

Introduction: Exclusive breastfeeding is a very old practice that has been losing relevance in recent years, generating a health risk for children under 6 months of age; however, health professionals can promote it through education, so that mothers can breastfeed consciously.

Objective: To determine the level of knowledge about exclusive breastfeeding among mothers attending in the Centro de Salud Zárate in Lima, 2024.

Method: Quantitative study, descriptive method, applied level and cross-sectional. The sample of 162 mothers, the survey technique and the instrument a questionnaire validated by expert judges, with a Content Validity Coefficient (CVCtc) of 0.88, which according to Hernández - Nieto is good.

Results: The mothers' level of knowledge about exclusive breastfeeding was medium with 56.1% (64), as well as in the general aspects and breastfeeding technique dimensions, they obtained 51% (58) and 54% (62), respectively.

Conclusions: Mothers presented a medium level of knowledge in general and in both dimensions regarding exclusive breastfeeding, revealing that there is little adherence when receiving the information, which implies that children in the first 6 months of life would not enjoy all the benefits provided by breast milk in the short and long term.

Keywords: knowledge, exclusive breastfeeding, mother, nursing baby.

DEDICATORIA

A Dios, porque es quien nos guía en este camino para actuar de forma correcta iluminándome con sabiduría para perseguir y lograr todos mi sueños y metas.

A mis padres, Vicente y Jessica, por haberme educado para ser una persona responsable y perseverante, acompañándome y celebrando todos mis logros durante mi formación profesional y personal.

A mis hermanos, Alessandro y Selene, por estar presente en cada paso de mi vida; y a mis primos y tías, que siempre han estado motivándome e impulsándome.

A mis amigos más cercanos de la universidad, Sam, Jordan, Jim y Flavia, que me han ido alentando y animando cada día para poder culminar la tesis.

AGRADECIMIENTO

A mi alma máter, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a cada uno de mis docentes que, en todos estos años de formación profesional, me inculcaron conocimientos valiosos para aplicar en la carrera como en la vida diaria.

A mi querida asesora de tesis, la Dra. Nancy Huamán Salazar, por su sabiduría, ímpetu, paciencia y dedicación durante el desarrollo de mi investigación, siendo una gran docente.

A mis mejores amigas, Alexandra, Shirley y Sara, por siempre estar, aunque muchas veces a la distancia; y a mi gran amigo, Airton, por haber sido mi apoyo y soporte en todo este proceso.

ÍNDICE

Resumen.....	2
Abstract.....	3
Dedicatoria.....	4
Agradecimiento.....	5
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.....	9
1.1. Planteamiento del Problema.....	10
1.2. Formulación del Problema.....	15
1.3. Objetivos.....	15
1.3.1. Objetivo General.....	15
1.3.2. Objetivos Específicos.....	15
1.4. Importancia y alcances de la investigación.....	15
CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LITERATURA.....	17
2.1. Antecedentes del estudio.....	17
2.1.1. A nivel internacional.....	17
2.1.2. A nivel nacional.....	18
2.2. Bases teóricas.....	22
2.2.1. Lactancia Materna Exclusiva en niños menores de 6 meses.....	22
A. Aspectos Generales de la Lactancia Materna Exclusiva.....	24
B. Técnica de Amamantamiento.....	26
C. Aspectos sociodemográficos de la madre y su relación con la lactancia materna exclusiva.....	29
2.2.2. Crecimiento y desarrollo del lactante menor de 6 meses.....	30
2.2.3. Rol de enfermería en la promoción de la lactancia materna.....	32
2.2.4. Generalidades sobre conocimiento.....	34
2.3. Definición operacional de términos.....	35
CAPÍTULO III. HIPÓTESIS Y VARIABLES.....	36
3.1. Hipótesis.....	36
3.2. Variable.....	36
CAPÍTULO IV. MATERIALES Y MÉTODOS.....	37
4.1. Tipo y método de investigación.....	37

4.2. Diseño de investigación.....	37
4.3. Sede de estudio.....	37
4.4. Población, muestra y muestreo.....	38
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	39
4.6. Procedimientos de recolección y procesamiento de datos.....	39
4.7. Análisis estadístico.....	40
4.8. Consideraciones éticas.....	41
CAPÍTULO V. RESULTADOS.....	42
5.1. Presentación de tablas y/o gráficos y descripción de los resultados...42	
5.1.1. Datos Generales.....	42
5.1.2. Datos Específicos.....	43
CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN.....	46
CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	50
7.1. Conclusiones.....	50
7.2. Recomendaciones.....	51
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	52
ANEXOS.....	62

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N°1: Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres que acuden al Centro de Salud Zárate en Lima, 2024.....	43
Gráfico N°2: Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en la dimensión aspectos generales en madres que acuden al Centro de Salud Zárate en Lima, 2024.....	44
Gráfico N°3: Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en la dimensión técnica de amamantamiento en madres que acuden al Centro de Salud Zárate en Lima, 2024	45

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

La lactancia materna es tan antigua como lo es la existencia de la humanidad, y los beneficios que conlleva se han ido descubriendo a lo largo de los años. Por ello, es importante el papel que una mujer cumple mediante la lactancia materna, ya que desde miles de años atrás se ha ido convirtiendo en un medio de supervivencia, pues la madre se convierte en el único ser que brinda alimento de subsistencia nutricional a los lactantes. ⁽¹⁾

En este aspecto, la sociedad debe brindar su apoyo a las madres constantemente para fomentar la lactancia materna, debido a su gran importancia al ponerla en práctica para así prolongarla en las futuras madres, para poder disminuir los abandonos de lactancia. Por lo cual, el profesional de enfermería tiene un rol fundamental en la promoción, protección y apoyo, a través de la educación que se brinda a las madres, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de dar de lactar. Por esto, es necesario desarrollar el presente estudio titulado “Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres que acuden a un Centro de Salud, Lima - 2024”, con el propósito de que, a partir de los resultados obtenidos, se pueda proporcionar una información actualizada a las autoridades de dicho establecimiento de salud, con la finalidad de que puedan implementarse estrategias que orienten a la promoción de una lactancia materna exclusiva.

Este trabajo de investigación consta de 7 capítulos; Capítulo I: Introducción, se encuentra el planteamiento, delimitación y formulación del problema, objetivos general y específicos, importancia y alcance de la investigación; en el Capítulo II: Revisión de la literatura, se exponen los antecedentes internacionales y nacionales, bases teóricas, definición operacional de términos; sigue el Capítulo III: Hipótesis y variable; luego el Capítulo IV: Materiales y métodos, que muestra el tipo, método y diseño de investigación, sede de estudio, población, muestra y muestreo, criterios de inclusión y exclusión, técnica e instrumento de recolección de datos con la validez del estudio, procedimiento de recolección y procesamiento de datos, análisis

estadístico y consideraciones éticas; Capítulo V: Resultados, contiene la presentación de gráficos con su descripción respectiva, tanto en los aspectos generales como específicos. Capítulo VI: Contiene la discusión de resultados, que presenta los hallazgos para la confrontación con los antecedentes y bases teóricas. En el Capítulo VII: Conclusiones y recomendaciones, que sintetiza todo lo analizado y brinda probables soluciones del tema en estudio. Por último, se encuentran las referencias bibliográficas y los anexos.

1.1. Planteamiento del problema

Durante ya algunos años, existe una mayor importancia por velar y cuidar a favor de la salud de los lactantes y las condicionantes que la alteran, debido a las diferentes enfermedades que pueden experimentar o padecer desde que llegan al mundo; el recién nacido no tiene la facilidad de digerir otro alimento que no sea leche materna ⁽²⁾; además que, cubre sus requerimientos nutricionales y eleva su sistema inmunológico, protegiéndolo de diversas enfermedades gastrointestinales, infecciosas, respiratorias, entre otras ⁽²⁾. Por tal motivo, la lactancia materna exclusiva es un indicador muy importante porque refleja el nivel de bienestar de un grupo etario específico. ⁽³⁾

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ⁽⁴⁾ refiere que cerca del 50% de todas las muertes en niños pequeños es causado por la desnutrición, y destaca que esto se debe a que la alimentación en los primeros meses de vida no ha sido la más adecuada; por ello, en unión con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), recomiendan que la lactancia materna debe iniciarse en la primera hora de vida del recién nacido, y que deben ser amamantados de forma obligatoria durante primer semestre de vida. De esta manera, el bebé podrá prevenir enfermedades crónicas no transmisibles como el sobrepeso y la obesidad; y la madre, se beneficia en que la involución uterina se realice en menor tiempo, además, se tiende a disminuir el riesgo de contraer cáncer mamario. ⁽⁵⁾

Según la UNICEF, en América Latina y el Caribe, este 2023, el 57% de los bebés no recibió leche materna exclusiva, esto se da mayormente en madres que deben salir a trabajar, y en sus centros laborales, no siempre cuentan con un espacio establecido como un lactario que les permita fortalecer la lactancia materna exclusiva (LME), por eso, la gran mayoría de madres debe escoger entre trabajar o amamantar, dejando de lado o en segundo plano la práctica de lactancia materna. ⁽⁶⁾

En Perú ⁽⁷⁾, las cifras de recién nacidos que recibieron leche materna durante su primera hora después del nacimiento, ha estado intentando recuperar las cifras anteriores a la pandemia, en donde si ha habido un aumento, ya que en el 2022 el 46.6% si la recibió; sin embargo, en 2023, solo el 48%. En la última actualización de datos estadísticos sobre la lactancia en los primeros minutos de vida, más de la mitad de los recién nacidos no fueron alimentados por sus madres durante ese periodo de tiempo. Además, el 34.1% no recibe lactancia materna de forma exclusiva en nuestro país, siendo las zonas urbanas en donde menos se pone en práctica (65.5%), a diferencia de las zonas rurales (78.3%), todo esto ocurre porque la mayoría de las madres que cuentan con estudios superiores o universitarios prefieren optar por fórmulas lácteas a diferencia de las que no tienen educación o solo han terminado su primaria. ⁽⁸⁾

Según las cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2023, el porcentaje de niñas y niños menores con hasta seis meses de edad que recibieron LME a nivel nacional, aumentó del 2022 (65.9%) al 2023 (69.3%). Según regiones, la Sierra y Selva presentan mejores estadísticas en comparación que la Costa con 61.1%, ya que ambas regiones antes mencionadas tienen 81.9% y 72.4%, respectivamente. Según la educación, las madres que no cuentan con ningún grado de instrucción o que tienen solo el nivel primario son las que brindan mayor LME obteniendo un poco más del 74%. Según los departamentos del Perú, y haciendo una comparación entre 2018 y 2023, se evidencia que los mayores porcentajes en el primer año

mencionado, fueron Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cajamarca y Loreto; mientras que en 2023; Ancash, Ucayali, Junín, y Puno, manteniéndose Cajamarca y Huancavelica con cifras que varían entre el 80% y 89.9%; y según los departamentos que presentaron peores estadísticas en el 2018, fueron Tumbes e Ica, al igual que en el 2023, con cifras que varían entre 28.6% y 48.5%. En Lima, las cifras se mantuvieron igual en el 2018 y 2023 con porcentajes que se encontraban entre 50% y 56.6% y la provincia constitucional del Callao también se mantuvo en ambos años con cifras entre 60% y 68.9%. ⁽⁹⁾

Cuando se carece de conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva se corre el riesgo de que la madre no cuente con las herramientas necesarias para amamantar de manera satisfactoria, sumado a la información distorsionada e incompleta que reciben por diversas fuentes de información o simplemente por el hecho de apegarse a costumbres familiares, ocurriendo el abandono de la lactancia, evidenciando un declive en las estadísticas ^(6,7,9). Por tal motivo, según López A. et al. en 2021, mencionan que numerosos estudios biológicos evidencian la radical decisión de la madre al no amamantar, lo cual genera daños a nivel físico del niño; afirmando que la alimentación en base a leche materna durante los primeros 6 meses es una estrategia sanitaria significativa para el bebé y la madre ⁽¹⁰⁾, e incluso, Gonzales A., et al. en 2022, consideran que ciertos elementos desfavorecen la LME, señalando el hecho de ser madre primeriza, tener escasa producción de leche materna, ser parte de una economía baja, y tener una situación laboral desgastante. Además, se incluye a la pandemia por COVID-19, ya que las madres en este contexto temían contagiar a sus bebés por medio de la LME, debido a la poca educación e información que se tenía. ⁽¹¹⁾

En Guatemala, un estudio por Marroquín F., Pichiyá S. y Pérez AG ⁽¹²⁾, en 2021, señalan que más del 60% de madres obtuvo un nivel de conocimiento medio, y cerca del 42% desconoce sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva.

Otra investigación realizada en Ecuador, por Albán I. y Yépez B ⁽¹³⁾, mencionan que casi el 40% de las madres asistentes a los centros de salud N°1 y N°4 brindaron lactancia en los primeros sesenta minutos de vida de sus bebés, y 12% de ellas aseveran erróneamente que la LME se realiza hasta los 3 meses de edad.

Estudios realizados en el Perú, demuestran que las madres desconocen ciertas características esenciales sobre la LME. Así, un estudio de Obregón J. ⁽¹⁴⁾ en 2018, Lima, realizado en un establecimiento de primer de nivel de atención llamado Tahuantinsuyo Bajo, señala que 49 % de madres desconocen sobre la importancia y los beneficios de la LME.

En otra investigación por Velázquez M. ⁽¹⁵⁾ en 2018, realizado en un centro de salud en Comas, se evidenció que casi el 54% desconoce sobre la importancia de brindar lactancia durante la primera hora de vida.

También, Bautista Y. y Díaz I. ⁽¹⁶⁾ en 2017, señalan en su estudio que más del 50% obtuvieron un nivel de conocimiento bajo y que 72% de las madres no realiza LME con sus bebés menores de 6 meses.

En este sentido, el enfermero que labora en los establecimientos del primer nivel de atención tiene la función de ayudar a prevenir las enfermedades en todas las etapas del ser humano, para intervenir oportunamente e inmediata de cualquier problema de salud ⁽¹⁷⁾ . Es por eso, que enfermería promociona, fomenta y educa sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva, para que el bebé crezca y se desarrolle adecuadamente.

Educar a las madres refuerza e incrementa sus conocimientos sobre el cuidado idóneo que un bebé necesita, ya que ellas son responsables del bienestar de sus hijos. Las enfermeras y enfermeros se cruzarán con madres de diferentes realidades, culturas y costumbres, por ello es primordial informar de forma clara, sencilla y precisa, para que la madre comprenda y entienda lo indispensable que es alimentar con leche materna durante los primeros seis meses de vida.

Durante las prácticas del internado en el Centro de Salud de Zárate, el cual es un establecimiento de primer nivel atención en donde se encuentran consultorios que brindan medicina general, obstetricia, tópico, CRED, ESNI, odontología, laboratorio, nutrición y PCT, funcionan todos los días de lunes a sábado y las colas que los pacientes realizan en admisión y en sala de espera son directamente proporcional a la demanda de pacientes que hay en el día, es por eso, que se observó la presencia de muchas madres adolescentes, jóvenes y adultas, quienes se encontraban en compañía de sus hijos, los cuales eran recién nacidos, niños pequeños y grandes, quienes acudían para su control de su crecimiento y desarrollo. Muchas veces las madres que acudían se encontraban sin algún familiar o acompañante, por lo que se veían estresadas y un poco fastidiadas al realizar todo el proceso de admisión y atención solas con sus niños en brazos y estando de pie intentaban distraer a sus pequeños por la demora en la atención. Asimismo, tanto las puérperas como las que tenían niños pequeños o grandes, lucían angustiadas al hablar sobre la lactancia materna exclusiva, ya que a veces por timidez o vergüenza no resuelven sus dudas al respecto; además, las que ya contaban con experiencia en la maternidad hacían comentarios referentes al tema, mencionando lo doloroso y agotador que es realizarlo; no obstante, se destacó que la mayoría presentaba iniciativa y disposición para brindar LME.

Las madres que se encontraban en la sala de espera con sus niños para su control de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano (CRED) manifestaban entre ellas: “Yo le doy mi pecho y no se llena, por eso le tengo que complementar con fórmula”, “la fórmula no le ha dado gases a mi bebé como me habían dicho por ahí”, “Me duele mucho la espalda, creo que le daré fórmula nomas”, “prefiero darle fórmula para que no me cause dolor”, “Mi bebé aún no sabe agarrar bien mi seno y por eso me lastima”, “yo he dado de mamar a mi hijo mayor por unos meses, luego le di fórmula y él está sanito”, “mi bebé no succiona mucho mi seno y casi no me sale leche”, “como no puedo producir mucha leche, le he tenido que dar fórmula, porque mi bebé llora de hambre”.

Después de todo lo mencionado amerita preguntarse: ¿Saben las madres la importancia de la lactancia materna exclusiva? ¿Conocerán las madres la técnica adecuada de amamantamiento? ¿La madre sabrá sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva? ¿Saben las madres hasta qué edad se debe realizar la lactancia materna exclusiva? ¿Conocerán el motivo del porqué no producen la suficiente leche materna?

1.2. Formulación del problema

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres de niños que acuden al Centro de Salud Zárate en Lima, 2024?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General:

Determinar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres de niños que acuden al Centro de Salud Zárate en Lima, 2024.

1.3.2. Objetivos Específicos:

- Identificar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en la dimensión aspectos generales en madres de niños que acuden al Centro de Salud Zárate.
- Identificar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en la dimensión técnica de amamantamiento en madres de niños que acuden al Centro de Salud Zárate.
- Identificar los datos sociodemográficos en las madres de los niños que acuden al Centro de Salud Zárate.

1.4. Importancia y alcance de la investigación

La lactancia materna exclusiva es el alimento esencial que un niño debe recibir durante los primeros 6 meses de vida, ya que incrementa su sistema inmunológico que lo protege de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y nutricionales para que crezca y se desarrolle favorablemente. Por tal motivo, es importante que la madre conozca sobre todo lo que concierne a la lactancia materna exclusiva, ya que con la información adquirida tendrá razones suficientes para saber cómo actuar a favor de la salud y bienestar de su hijo, evitando dificultades físicas y psicoemocionales a corto y a largo plazo.

El profesional de enfermería que labora en el primer nivel de atención se encarga de promocionar y educar sobre la LME, abordando sobre todo a las madres y mujeres gestantes, únicas encargadas de alimentar a sus hijos durante los primeros 6 meses. Por ello, proporcionar charlas educativas y demostrativas permitirá un impacto positivo y reflexivo que fortalecerá la decisión de declive sobre lactancia; y junto al Ministerio de Salud del Perú (MINSA) ⁽¹⁸⁾, el cual creó una guía técnica sobre lactancia materna como recurso educativo, en donde se destacan las ventajas o beneficios que proporciona al niño, madre, familia y sociedad, así como los riesgos y consecuencias que se pueden presentar cuando el bebé no es amamantado.

Los resultados obtenidos en este estudio aportarán diferentes planes y estrategias educativas como consejerías que generen conciencia sobre la importancia de la LME, con el fin de difundirla y promoverla. Inclusive, ayudará a realizar un reconocimiento de la realidad actual, pues a pesar que existe mayor información se identifican aspectos que necesitan ser reforzados. Por último, será de utilidad para los próximos investigadores que realicen un estudio referente al tema.

Asimismo, los resultados fidedignos permitirán a la enfermera educar a la madre sobre los puntos más relevantes de la lactancia materna exclusiva, como: el periodo de duración de una LME efectiva, la importancia de amamantar, los beneficios a corto y a largo plazo en la salud infantil y

materna, la medida higiénica y preventiva para preparar el seno materno antes de dar de lactar; posición y técnica adecuada que debe optar el lactante y la madre; y la frecuencia con la que se debe brindar para que el niño no pierda peso y crezca saludablemente ⁽¹⁹⁾, con la finalidad de corregir, pero sobre todo ampliar sus conocimientos sobre el tema.

CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. Antecedentes del estudio

2.1.1. A nivel Internacional

Arcentales J., en 2023, Ecuador, realizó un estudio con el objetivo de evaluar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres de lactantes internadas en el Hospital Pediátrico Baca. Investigación descriptiva, observacional y de corte transversal. La muestra poblacional con 102 madres. El instrumento un cuestionario. Resultados: 56,8% de las madres tienen nivel de conocimiento medio y el 10.7% conocimiento bajo sobre lactancia materna exclusiva. Conclusión:

“Las madres estudiantes, amas de casa, trabajadoras independientes y dependientes poseen un nivel de conocimiento medio; sin embargo, las que cursaron nivel superior alcanzaron un nivel alto”.⁽²⁰⁾

Marroquín F., et al. en 2021, en Guatemala, hicieron una investigación con el objetivo de identificar el conocimiento sobre lactancia materna exclusiva y las características demográficas de las madres. Estudio descriptivo, transversal y cuantitativo. La muestra poblacional 301 madres. Técnica encuesta e instrumento un cuestionario. Resultados: 38,7% de las madres desconocen sobre la lactancia materna exclusiva y sus beneficios. Como conclusión indican:

“La mayoría de las madres tiene un nivel medio de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva y manifiestan que lo adquirieron principalmente en los servicios de salud”.⁽¹²⁾

Mamani Y., et al., desarrollaron un estudio titulado “Conocimientos y prácticas sobre lactancia materna en Cochabamba – Bolivia: un estudio departamental, 2017”. Investigación poblacional, observacional y descriptiva de corte transversal. La muestra poblacional 3515. La técnica encuesta y el instrumento un cuestionario estandarizado. Resultados: 14,1% no tiene conocimiento sobre el inicio temprano del amamantamiento y 19,2% no conoce la duración de una lactancia materna exclusiva. Entre sus conclusiones menciona:

“Los índices elevados en lactancia materna exclusiva se ven asociados a factores sociodemográficos como la edad, escolaridad y región de residencia”. ⁽²¹⁾

Albán I. & Yépez B, en 2016, Ecuador, elaboraron una investigación que tiene como objetivo describir los conocimientos, actitudes y prácticas sobre lactancia de las madres que acuden a diferentes Centros de Salud en Quito. Estudio cuantitativo y de corte transversal. La muestra poblacional 212 madres. La técnica una encuesta y el instrumento un cuestionario con preguntas de opción múltiple. Resultados: 36% desconoce que la lactancia materna inmediata se brinda durante la primera hora de vida del bebé y 37% no conoce la duración de la lactancia materna exclusiva. Entre las conclusiones destacan:

“Los conocimientos de las madres educados de forma adecuada por el personal de salud conlleva a una práctica adecuada de LME, mientras que las creencia o mitos cual influye negativamente”. ⁽²²⁾

2.1.2. A nivel Nacional

Berrocal M., Flores B. & Solano A., en 2021, en Huancayo, hicieron un estudio denominado “Conocimientos y prácticas sobre la lactancia materna en madres adolescentes en el Centro de Salud Chilca”. Pesquisa cuantitativa, descriptiva y de corte transversal - correlacional no experimental. La muestra poblacional 60 madres. Técnicas empleadas encuesta y guía de observación, el

instrumento un cuestionario. Resultados: 46,67 % de madres presenta un nivel de conocimientos regular y 18,33% un nivel deficiente en lactancia materna exclusiva. Además, en su dimensión ventajas evidencia un 63.3% con nivel deficiente y 30% regular y en técnica de amamantamiento 75% tiene fue nivel regular. Se concluye que:

“Mientras mayor conocimiento se obtiene durante la experiencia de ser madre, se va adquiriendo un grado más alto de responsabilidad por cuidar de sus hijos, lo cual favorece la práctica de la LME”.⁽²³⁾

Palomino N., en 2019, Cañete, elaboró una investigación con objetivo de evaluar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna en puérperas del Hospital Rezola. Estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental y de corte transversal. Población 180 madres y su muestra 123. Técnicas empleadas encuesta y guía de observación, el instrumento un cuestionario. Resultados: 65 % de las madres presentaron nivel de conocimiento medio sobre lactancia materna exclusiva y 28,5% bajo. Entre sus conclusiones:

“La mayor proporción de madres presenta nivel de conocimientos medio sobre LME, en donde el grado de instrucción y la cantidad de hijos son aspectos que influyen”.⁽²⁴⁾

Bocanegra J. & Calderón G., en 2019, Amazonas, realizaron una investigación titulada “Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres primerizas del Hospital María Auxiliadora Rodríguez de Mendoza”. Estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. La muestra poblacional fue 41 madres. La técnica encuesta y el instrumento un cuestionario. Resultados: 65,9% presentó nivel de conocimientos medio en dimensión generalidades; en ventajas para el niño: 46,3% conocimiento medio y 43,9% conocimiento bajo; y ventajas para la madre: 73.2% conocimiento bajo. Dentro de sus conclusiones se encontraron:

“La mayoría de las madres presentan niveles de conocimiento bajo, lo cual se ve influenciado por las condiciones sociales y culturales que poseen, incluido los factores biológicos como edad y madurez”. (25)

Vásquez P., 2019, en Cajamarca, efectuó un estudio denominado “Conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de seis meses. Centro de Salud Pachacútec”. Investigación no experimental, descriptivo, de corte transversal y correlacional. La población fue 720 madres y la muestra 85. La técnica fue entrevista directa y el instrumento un cuestionario. Resultados: 47,1% de las madres obtuvo nivel de conocimiento medio sobre lactancia materna exclusiva, y 3.5% nivel bajo. Concluyendo que:

“El grado de instrucción y la ocupación de la madre si influye en el conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva”. (26)

Marquina P., en Lima, realizó una investigación titulada “Nivel de conocimiento de las madres de menores de seis meses sobre lactancia materna exclusiva en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Sergio E. Bernal en el periodo noviembre-diciembre, 2018”. Estudio cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. La población 84 madres y la muestra 39. La técnica fue encuesta y el instrumento un cuestionario. Resultados: 46% de las madres presentan nivel de conocimiento medio sobre lactancia materna exclusiva y 26% nivel bajo”. Entre sus conclusiones:

“La mayoría de madres poseen un nivel de conocimiento medio sobre LME; debido a que, existiría una diferencia en la educación que se brinda dentro de un área rural en comparación de una urbana”. (27)

Velásquez C. en 2017, en Chimbote, desarrolló una pesquisa con el objetivo de determinar los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres de lactantes menores de 6 meses que acuden a un centro de salud. Investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional y transversal. La población fue 195 madres y la muestra 130. Técnica encuesta e instrumento

un cuestionario. Resultados: 42,31% obtuvo nivel de conocimientos medio y 32,31% bajo. Dimensión aspectos básicos: 40% nivel medio y 30,77% bajo; importancia: 46,92% medio y 31,54% bajo; beneficios y ventajas: 42,31% medio y 34,62% bajo. Se concluye que:

“Las madres siguen evidenciando altos índices de desinformación en lactancia materna exclusiva, por lo que adquirir conocimiento es importante para su ejecución, y sobre todo continuidad”. ⁽²⁸⁾

Baila B. y Quevedo M., en 2016, en Lambayeque, ejecutaron un estudio denominado “Relación entre conocimientos y prácticas sobre lactancia materna en madres del Programa de Crecimiento y Desarrollo en el Hospital Referencial de Ferreñafe”. La investigación de tipo cuantitativa descriptiva. La población 384 madres y la muestra 214. Técnica encuesta y el instrumento un inventario. Resultados: 89,7% de madres tienen un nivel de conocimiento medio sobre lactancia materna. Dentro de las conclusiones:

“El profesional de enfermería debe educar a las madres para que estas tengan una base de conocimientos científicos que fortalezca la lactancia que contribuya con la evolución adecuado del lactante”. ⁽²⁹⁾

García LA., en 2015, en Lima, realizó una investigación titulada “Nivel de conocimientos de las madres menores de seis meses acerca de la lactancia materna exclusiva en el Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo”. Estudio descriptivo y corte transversal. La población 70 madres y la muestra 60. Técnica una entrevista y el instrumento un cuestionario. Resultados: 51,6% tiene conocimiento medio y 41,7% bajo sobre lactancia materna exclusiva. En conclusión:

“Es importante la educación que brinda el profesional de salud para incrementar los conocimientos y promover la lactancia materna exclusiva que repercute favorablemente en el crecimiento y desarrollo saludable del lactante”. ⁽³⁰⁾

En este estudio cada aporte bibliográfico utilizado reafirma que hay necesidad de conocimiento en las madres de familia, permitiendo contextualizar la realidad del problema, reflejando los aspectos o elementos que interfieren o influyen ya sea a favor o en contra de la información que las madres reciben a través de las estrategias educativas actuales, y de esa manera se puede considerar mejores criterios de inclusión o exclusión al realizar esta investigación. Además, notificará a las instituciones públicas sanitarias para que realicen intervenciones educativas y consejerías teniendo en cuenta las necesidades fundamentales que la madre evidencie y así incrementar la práctica de la lactancia materna exclusiva a base de conocimientos científicos y por supuesto fomentando concientización.

2.2. Bases teóricas:

2.2.1. Lactancia Materna Exclusiva en niños menores de 6 meses

2.2.1.1. Bases conceptuales de la Lactancia Materna

Según la OMS, la lactancia materna es la forma de alimentación más eficaz para garantizar el bienestar, la salud y supervivencia de los lactantes ⁽³¹⁾, ya que la leche materna es el alimento principal y esencial que brinda los nutrientes necesarios al infante durante los 2 primeros años de vida, tomando mayor relevancia en los primeros seis meses. ⁽¹⁸⁾

2.2.1.2. Fisiología de la lactancia materna

Cuando una mujer se encuentra en estado de gestación, sus senos atraviesan un proceso de preparación y desarrollo para cumplir una función primordial, alimentar al recién nacido. Ambos senos estarán listos para brindar leche materna desde la semana 16 de gravidez sin la necesidad de intervenir o manipularlas. ⁽³²⁾ El inicio para excretar leche materna o también llamado lactogénesis, se describe mediante tres estadios: el primero inicia unas doce semanas antes del parto, el segundo pocos días postparto cuando la secreción de leche es copiosa, y el tercero, es el mantenimiento de la lactancia ya constituida. ⁽³¹⁾

2.2.1.3. Fisiología de la glándula mamaria

La leche materna es producida por células que se hallan en la glándula mamaria, las cuales recorren por los alvéolos para almacenarse y terminar secretando mediante los conductos lactíferos. En cuanto a la producción de la leche materna, se va a necesitar de dos hormonas importantes; las cuales son: prolactina, la cual permite la producción, y oxitocina, realiza la secreción. Ambos senos maternos van a depender de una la calidad de succión realizado por el lactante. ⁽³²⁾

Anatomía de los senos maternos: llamadas también mamas, se componen de tejido de soporte, glandular y adiposo. Se sitúan entre el 2do y 6to espacio intercostal de la pared torácica, favoreciendo la posición del bebé en la lactancia. Las mamas son diferentes en cada mujer, porque cuentan con características individuales; sin embargo, no interfiere con la producción de leche materna. ⁽³³⁾

El pezón: se encuentra en el medio de la areola y posee fibras musculares lisas que actúan como un músculo anular de apertura y cierre para los conductos y senos galactóforos, se encuentra conformado por muchas terminaciones nerviosas, sensitivas y anastomosis arteriovenosas. ⁽³⁴⁾ Además, es la marca o señal de referencia para que el bebé encuentre el seno materno, y es por donde la leche va ser excretada hacia el exterior. ⁽³⁵⁾

Areola: zona pigmentada o teñida de color oscuro y en forma circular que contornea el pezón y posee diversas glándulas sudoríparas y sebáceas independientes, se apertura en los tubérculos de Montgomery (estímulo olfativo). ⁽³⁴⁾

Tejido mamario: se compone de glándulas mamarias, conductos galactóforos, tejido de sostén (tejido mamario denso) y tejido graso (tejido mamario no denso). Está vascularizado por vasos perforantes de la arteria y venas mamarias internas, así como de los vasos torácicos laterales. ⁽³⁶⁾

2.2.1.4. Composición de la leche materna

Macronutrientes: está constituido por carbohidratos, el azúcar principal es la lactosa, la cual mantiene la densidad de la leche a través del agua. También, se encuentran oligosacáridos como: glucosa, galactosa, entre otros; estos engloban 1.2% de leche materna. Luego, se encuentran las grasas, que presentan muchas modificaciones, ya que varían en el tiempo y brindan hasta 55% de kilocalorías, su mayor componente los triglicéridos y se ha demostrado que los ácidos grasos poliinsaturados están presentes; además de brindar provecho a nivel del sistema nervioso central (SNC). También se ubican las proteínas, que constituyen 0.9% de leche materna, en donde la caseína ocupa un 40% y el restante se basa en lisozima, lactoalbúmina, lactoferrina (absorción del hierro en el intestino); y posee inmunoglobulinas, en donde la IgA secretora cumple una función fundamental como protectora. ⁽³⁷⁾

Micronutrientes: se compone de vitaminas presentes en la leche materna; sin embargo, en un recién nacido las concentraciones de potasio son bajas, por ello se aplica una dosis de vitamina K al nacer. Después, los minerales y elementos trazas están en cantidades suficientes y necesarias para un lactante. ⁽³⁷⁾

Otros componentes: se encuentra el agua, componente en mayor proporción que presenta la leche materna (hasta 90%) y la cual si se encuentra asociada con la ingesta de líquidos por parte de la madre; también encontramos los nucleótidos, quienes incrementan la respuesta inmunológica, mejorando el perfil lipídico y contribuyendo con la maduración del epitelio intestinal. ⁽³⁷⁾

A. Aspectos generales de la Lactancia Materna Exclusiva

A.1. Definición de Lactancia materna exclusiva (LME)

Se refiere a la acción de brindar leche materna al bebé, sin la necesidad o urgencia de añadir otros alimentos en forma líquida o sólida. ⁽³⁸⁾ También, se

le considera un proceso biológico que atraviesa la mujer cuando se convierte en madre, pues es la que tiene la obligación de alimentar al recién nacido hasta los 6 meses de edad a través del seno materno, facilitando su crecimiento y desarrollo saludable. ⁽³⁹⁾ La leche materna ofrecida directamente del seno materno al niño, es el único alimento que al ser ingerido adecuadamente proporciona los nutrientes necesarios de forma satisfactoria, y adicionalmente genera anticuerpos para protegerlo de diversas enfermedades. ⁽⁴⁰⁾

A.2. El Inicio temprano de la lactancia materna exclusiva

Es fundamental recibir lactancia materna durante la primera hora de vida del recién nacido, ya que es el periodo de tiempo en donde la madre empieza a producir el calostro, el cual es un líquido amarillo denso, nutritivo y de protección, además de que es fácil para la digestión del lactante. ⁽⁴¹⁾ También, ayuda a reducir el riesgo de mortalidad del casi 20% en el primer mes de nacido. ⁽⁴²⁾

A.3. Importancia de la Lactancia Materna Exclusiva

La lactancia materna exclusiva nutre al niño en favor a un crecimiento y desarrollo apropiado, actuando como protector de enfermedades, infecciones y alergias. Por ello, se reduce la probabilidad de que pueda desarrollar enfermedades no transmisibles como obesidad y sobrepeso en la infancia o en la adultez. ⁽⁴³⁾

A.4. Tipos de leche materna

Calostro: primera leche de color amarillenta producido por el seno de la madre que se genera durante los primeros 3 o 4 días postparto. Su producción se encuentra entre 40 y 50 ml por día, suficiente para el estómago de un recién nacido. ⁽³⁷⁾ Se compone de 87% agua, 2.9g/100 ml. grasa; 5.5g/100ml lactosa y 2.3g/ 100 ml. de proteínas. ⁽³⁶⁾

Leche de transición: Es excretado durante el cuarto y décimo día postparto ⁽³³⁾, en el quinto día de ese periodo se incrementa exageradamente la

producción y aumenta su volumen hasta llegar a 600 ml/día durante la segunda quincena posparto. ⁽⁴⁴⁾

Leche madura: Es la leche blanquecina que tiene un volumen aproximado de 800 ml/día, que tiene una duración coincidente con el tiempo que se brinda lactancia materna exclusiva (6 meses). ⁽⁴⁴⁾

A.5. Beneficios de la Lactancia Materna Exclusiva

Lactante: favorece de forma física y emocional su desarrollo, disminuye el riesgo de contraer enfermedades a corto y largo plazo, ayuda con una buena digestión evitando el estreñimiento y acumulación de gases, fortalece el vínculo emocional y afectivo con la mamá y genera una mayor inteligencia intelectual. ⁽⁴⁵⁾

Madre: ayuda en la recuperación postparto con una involución del útero más efectiva y en menor tiempo, brinda menor riesgo de sufrir sobrepeso y obesidad, disminuye la probabilidad de padecer cáncer de mama, de ovario, y osteoporosis, genera mayor satisfacción personal y fortalece la autoestima, e incrementa los lazos afectivos con el lactante. ⁽⁴⁵⁾

Familia: disminuye los gastos económicos del sustento familiar evitando compras de fórmulas lácteas, se reduce la ausencia laboral y mayor tranquilidad para que los padres trabajen debido a que el niño se encontrará saludable, fortalece el contacto afectivo y emocional entre el bebé y la familia, brinda disponibilidad inmediata y reduce el tiempo a la hora de brindar la comida, pues no hay necesidad de preparar la leche en biberones. ⁽⁴⁵⁾

B. Técnica de amamantamiento

La madre tiene la libertad de elegir la posición más cómoda para ella y la cual le genere mayor facilidad al dar de lactar; no obstante, debe cerciorarse de que la técnica utilizada sea correcta. ⁽⁴⁶⁾

B.1. Medidas de higiene

Existen ciertas medidas de higiene y/o prevención que la madre tiene que realizar para amamantar, como: el lavado de manos con agua y jabón, que se hace antes de dar lactar; y el aseo personal, que debe ser diariamente. ⁽⁴⁷⁾

B.2 Posición de la madre

La madre cuando realice la lactancia materna en la posición que elija, debe sentirse cómoda y confortable, teniendo en cuenta que su espalda siempre debe estar apoyada. Por ello, es importante que conozca las características de una técnica adecuada en donde involucre un buen agarre y succión por parte del lactante, y así no se genere heridas o grietas en el seno materno. Existen las siguientes posturas para dar de lactar: ⁽⁴⁸⁾

De cuna o sentada: el bebé es colocado con el tronco enfrente y pegado al de la madre, la cual lo tiene cargado entre sus brazos; mientras que la cabeza del lactante debe estar apoyada en la flexión del codo de la madre, y con ayuda de su mano libre debe coger su seno para acercar al bebé.

Acostada: la madre está yacente junto al bebé, ambos con su cuerpos enfrente y pegados, utilizando su mano libre para siempre mantenerlo cerca. Es la posición más utilizada para las noches y durante los primeros meses del lactante.

Crianza biológica: la madre está recostada en posición semifowler mirando hacia arriba, y el bebé hacia abajo. Es la posición que se utiliza para ayudar a que el bebé tenga un mejor agarre y la madre no sufra mucho dolor.

Balón de rugby o invertida: se colocan las piernas del bebé apuntando hacia atrás (espalda de la madre) por debajo de la axila a nivel del seno, la madre debe agarrar el cuello y los hombros, sin tocar la cabeza para obtener un buen acoplamiento.

Caballito: el bebé está recostado sobre una de las piernas de la madre y se encuentra pegado a su abdomen. La madre con ayuda de su dedo índice y pulgar lo toma por detrás de las orejas, mientras que su muñeca junto al brazo

va en el dorso del bebé. Se utiliza cuando la madre presenta dolor y heridas en los senos.

Es importante que cuando se realice el acercamiento de la boca del bebé con el seno de la madre, la mano libre tiene que coger el seno que va a utilizar en forma de “C” y verificar que el lactante tome el pezón y gran parte de la areola con la boca bien abierta. ⁽⁴⁹⁾

B.3. Posición del lactante

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: ⁽⁴⁹⁾

1. La cabeza y todo el cuerpo del bebé debe estar inclinado siguiendo el eje del seno materno.
2. La cara del bebé debe estar frente al seno materno y su tronco enfrentado con el de la madre.
3. La proyección de la oreja, hombro y cadera tiene que dar como resultado una línea recta.

B.4. Signos de un buen agarre

Un agarre correcto del lactante es cuando: ⁽¹⁸⁾

1. Su boca está bien abierta y encierra la mayoría o gran parte de la areola
2. Su labio inferior está hacia afuera (evertido)
3. Su mentón debe tocar el seno materno
4. Contiene más areola en la parte inferior que superior

B.5. Signos de una buena succión

Cuando el lactante succiona de manera efectiva es porque el agarre es adecuado, esto indica que la leche materna está fluyendo apropiadamente.

Se considera una buena succión cuando: ⁽⁵⁰⁾

- Las succiones son lentas y profundas, con una deglución visible o audible.
- Las succiones deben tener pausas cortas, permitiendo el llenado de leche. Al final de cada mamada, la succión tiene que ser menos profunda con pausas más prolongadas.
- Las mejillas del lactante mientras succionan deben permanecer redondeadas.

B.6. Signos de una mala succión y agarre

Cuando no hay una succión efectiva, sus consecuencias son: ⁽¹⁸⁾

- Obstrucción de los conductos lactíferos del seno materno, lo que podría generar grietas o heridas.
- Absorción insuficiente, lo que genera una baja o nula ganancia de peso en el lactante.
- Rechazo del seno materno por parte del lactante.

B.7. Duración y frecuencia de las mamadas

La frecuencia de mamadas en los lactantes es variable, ya que toman diferentes cantidades de leche en cada una de ellas, pero es importante que la madre sepa que la lactancia debe ser a demanda o de 8 a 12 veces por día aproximadamente, que significa dar de lactar cada 2 o 3 horas como máximo ⁽¹⁸⁾, puesto que si el niño tiene mamadas muy prolongadas, es decir, más de 30 minutos, o tiene la necesidad de hacerlo de manera muy frecuente, cada 1h o 1h y 30min, se tiene que verificar continuamente el agarre y la succión para tener la seguridad de que se está alimentando de forma adecuada. ⁽⁵⁰⁾

C. Aspectos sociodemográficos de la madre y su relación con la lactancia materna exclusiva

Durante la práctica de la lactancia materna exclusiva existen diferentes tipos de barreras que van a interferir para que esta sea exitosa. Es así como la

UNICEF ⁽⁵¹⁾, menciona que las madres deben enfrentar adversidades que se relacionan con aspectos sociales, culturales y laborales, a pesar de que sean conscientes de los beneficios que brinda la leche materna como alimento para su niño o niña durante sus primeros seis meses de vida.

Uno de los aspectos más relevantes para que la madre realice una práctica adecuada de lactancia materna exclusiva es el grado de instrucción, ya que a los estudios se relacionan de forma directa con el conocimiento y a una mejor comprensión de los beneficios e importancia que brinda el amamantar. Ya que, según varios estudios las madres universitarias son la población en donde predomina la lactancia materna exclusiva, asimismo, existe una discrepancia con otros estudios que manifiestan que el mismo aspecto puede afectar la continuidad de su práctica por sus actividades laborales fuera de casa, pues, existe una proporción directa con la ocupación de la madre, ya que las son amas de casa brindar mayor lactancia materna que las que estudian o trabajan. También, otros autores afirman que cuando una mujer se convierte en madre por primera vez suele no realizar una lactancia materna exitosa los primeros 6 meses de vida, debido a la influencia familiar, o por el inicio de la maternidad en una etapa adolescente, e incluso por la presión social debido al cambio corporal que atraviesan durante el embarazo y post parto.^(52,53)

2.2.2. Crecimiento y desarrollo del lactante menor de 6 meses

2.2.2.1. Desarrollo Motor: proceso en donde adquiere habilidades motoras de manera continua y secuencial, iniciando con movimientos sencillos y vagos, progresando a movimientos más finos y organizados. ⁽⁵⁴⁾ Se divide en:

Motricidad gruesa: es la que se desarrolla inicialmente con movimientos grandes. Se utilizan grupos grandes de músculos para lograr el movimiento, equilibrio y estabilidad, como: gatear, caminar, saltar, etc. ⁽⁵⁴⁾

Motricidad fina: movimientos finos con partes pequeñas del cuerpo como: dedos (ya se de las manos o pies), boca, lengua, etc. ⁽⁵⁴⁾.

Ambos tipos de motricidad se complementan, ya que se necesitan para realizar los movimientos de forma articulada. El progreso del desarrollo motor:

Recién nacido hasta los 3 meses de edad:

En este periodo de tiempo presenta diferentes reflejos como: el de búsqueda, que se refiere a que el bebé abra la boca buscando en dirección al seno materno para poder alimentarse, este reflejo tiene una duración de alrededor de 4 meses; de succión, es cuando el paladar del bebé entra en contacto con algo y empieza a succionar, aunque no sea el seno materno; de prensión, se acaricia la palma del bebé y cierra inmediatamente con un apretón, este reflejo desaparece a partir de los 5 o 6 meses; de moro, es cuando el bebé sobresalta al escuchar algún sonido o movimiento. Además de todo ello, presenta mayor concentración en la mirada, sigue objetos en movimiento y hacia la luz, puede levantar el cuello cuando esta boca abajo, sonríe, empieza a coger objetos con las manos con mayor fuerza y puede sostener un tiempo más duradero su cabecita (3 meses). ⁽⁵⁵⁾

Bebé de 4 a 6 meses:

Tiene mejor resistencia de su cabeza y cuello, reacciona al sonido, voltea con mayor facilidad y rapidez, ríe al mirar su reflejo, agarra objetos grandes, gira cuando se le coloca boca abajo y empieza a sentarse sin caer hacia los lados. ⁽⁵⁴⁾

2.2.2.2. Desarrollo Verbal: es la forma de comunicación que tiene el bebé con su alrededor para expresar sus necesidades o incomodidades. ⁽⁵⁵⁾

Recién nacido a 3 meses:

El llanto es su única forma comunicativa y tiene diferentes significados como: hambre, sueño o molestia, responden con expresiones faciales cuando se les habla. En el mes dos, empiezan a balbucear vocales y emiten sonidos utilizando letras del abecedario como la “g”, “k” y “j”. ⁽⁵⁵⁾

Bebé de 4 a 6 meses:

Emiten sonidos con dirección a alguien, empiezan a gritar intencionalmente hasta reírse, reconocen las voces de sus parientes (sobre todo de mamá), e imitan ciertos sonidos. ⁽⁵⁵⁾

2.2.2.3. Desarrollo Cognitivo: proceso que permite al bebé adquirir conocimientos y empezar a desarrollar habilidades y capacidades intelectuales. ⁽⁵⁵⁾

Recién nacido a 3 meses:

Duerme mucho y solo despierta para alimentarse o porque su pañal está sucio, los sonidos le empiezan a llamar la atención y reconocerá levemente a sus padres y personas con más contacto. ⁽⁵⁵⁾

Bebé de 4 a 6 meses:

Expresa risas perdurables y hace fuertes sonidos, presta mayor atención al ruido externo y voltea, reconoce con mayor claridad a sus padres y empieza a rechazar a gente desconocida, disfruta más jugar. ⁽⁵⁵⁾

2.2.3. Rol de enfermería en la promoción de la lactancia materna

El profesional de enfermería tiene la función de brindar educación a la madre desde la gestación hasta el nacimiento del bebé sobre la importancia de amamantar y la técnica adecuada al hacerlo, fomentando su práctica y reforzando que debe ser exclusiva durante 6 meses, para luego introducir la alimentación complementaria que puede ser brindada paralelamente junto a la leche materna hasta los 2 años de edad. Puesto que, la enfermera está encargada del Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano (CRED) forma periódica o mensual durante el primer año del lactante, es importante que ofrezca herramientas y consejerías educativas a las madres para facilitar la práctica de la lactancia materna exclusiva.

Asimismo, los enfermeros y enfermeras tienen el trabajo de concientizar a las madres de familia sobre la importancia de amamantar, enfatizando en las

ventajas que le ofrece al niño, a ellas mismas, a sus familias e incluso a la sociedad en general. ⁽⁵⁶⁾

2.2.3.1. En los establecimientos de salud I-4

Es la categoría que se encuentra responsable de satisfacer las necesidades sanitarias de la población en su ámbito jurisdiccional, mediante una atención de salud integral, ambulatoria y de corta estancia, y tiene como función primordial el área Materno-Perinatal e infantil, promocionando la salud, previniendo daños, recuperando la salud a través de diagnósticos y tratamientos de las enfermedades más frecuentes con mayor grado de dificultad y rehabilitando la salud identificando a la población más vulnerable que presenten algún riesgo de discapacidad y continuando con los procedimientos indicados. Además, se realiza la atención de los partos eutócicos y la atención básica inmediata del recién nacido, teniendo en consideración las características culturales de la madre en turnos diurnos y nocturnos que garanticen una atención de 24 horas diariamente. ⁽⁵⁷⁾

Las acciones o intervenciones por parte del profesional de enfermería en el puerperio inmediato y la atención inmediata del neonato, considerando un estado de salud adecuado y estable para ambos, son las siguientes: colocar a la madre y al recién nacido contacto piel con piel el mayor tiempo posible, intentar el acoplamiento del bebé al seno materno para el inicio temprano de la lactancia materna mientras se educa sobre su importancia y beneficios para el neonato y la recuperación más rápida de la madre, luego se los debe llevar juntos para alojamiento conjunto para la continuación de la alimentación del recién nacido, en donde se le brindar nuevamente educación a la madre sobre cómo debe ser una técnica adecuada de amamantamiento. ⁽⁵⁸⁾

2.2.3.2. Teoría de Ramona Mercer: Adopción del rol maternal

La teórica Ramona Mercer plantea que el profesional de enfermería tenga en cuenta todos los componentes imprescindibles que permitan a la mujer una mejor adaptación al rol maternal, en donde las redes de apoyo involucradas como la familia, los centros laborales, y otros organismos a favor de la

sociedad sean de ayuda en esta fase. Añadido a eso, sustenta que la madre atraviesa por un periodo evolutivo, interactivo y difícil, generando el vínculo con su recién nacido y empezará a adquirir nuevos saberes sobre el rol que está viviendo, sintiendo armonía, tranquilidad, familiaridad, confianza y competencia, que le genera esta nueva identidad. ⁽⁵⁹⁾

2.2.4. Generalidades sobre conocimiento

2.2.4.1. Concepto de conocimiento

Es la acción de adquirir información acumulada y valiosa que permite la comprensión de la realidad por medio de la razón y entendimiento sobre un tema en específico. ⁽⁶⁰⁾

2.2.4.2. Nivel del conocimiento

Describe la medida de una cantidad en relación a una escala determinada. ⁽⁵⁶⁾ Según Columbié M. et al ⁽⁶¹⁾, cuando se divide el percentil 100 en tres categorías, se obtiene el percentil 33 y 66, obteniendo los siguientes niveles: alto, cuando el valor promedio de respuestas correctas está por encima del percentil 66; medio, cuando se encuentra entre el percentil 33 y 66; y bajo, inferior al percentil 33.

2.3. Definición operacional de términos

Conocimiento: información que las madres poseen sobre lactancia materna exclusiva teniendo en cuenta su propia experiencia y de otros medios de aprendizaje.

Lactancia materna exclusiva: es el tipo de alimentación basada sólo en leche materna que la madre proporciona a su hijo durante los primeros 6 meses de vida, y a libre demanda.

Leche materna: es el alimento natural originado por las glándulas mamarias de las madres y que contienen nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo adecuado del lactante.

Madre de un lactante: persona de sexo femenino responsable de amamantar a su hijo durante los primeros seis meses de vida.

Lactante: niño o niña que se alimenta de forma directa y exclusiva de leche materna.

Centro de Salud: establecimiento de salud del primer nivel de atención con actividades que promueven la lactancia materna exclusiva para prevenir enfermedades en los lactantes.

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLE

3.1. Hipótesis:

No aplica en la investigación porque es un estudio descriptivo, que su objetivo es la recolección de datos sin la manipulación de la variable.

3.2. Variable:

Variable de estudio: Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva, es de naturaleza cualitativa ordinal.

CAPÍTULO IV: MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Tipo y método de investigación

Estudio de tipo cuantitativo porque los datos fueron medibles, lo cual contribuyó a determinar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva a partir de los resultados obtenidos. De nivel aplicativo, porque los resultados brindaron información valiosa para guiar al profesional de enfermería a mejorar las futuras estrategias educativas sobre lactancia materna exclusiva; método descriptivo, porque se describieron los fenómenos hallados; y, prospectivo, ya que los datos y la información se registraron según fueron ocurriendo los hechos. ⁽⁶²⁾

4.2. Diseño de investigación

El diseño de investigación es no experimental porque no hubo manipulación de la variable de estudio, lo cual permitió observar los fenómenos en su contexto natural; y de corte transversal, porque la variable se estudió en un periodo determinado. ⁽⁶²⁾

4.3. Sede de estudio

El estudio se realizó en el Centro de Salud Zárate, que es un establecimiento de salud I-3, el cual se encuentra ubicado en la Calle Los Chasquis 1084, en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima – Perú, perteneciente a la DIRIS Lima Centro.

Este establecimiento de salud se encuentra dentro del primer nivel de atención por tener el primer contacto con la familia y la comunidad, los servicios que brindan de manera ambulatoria son: medicina externa, tópico, PCT (Programa contra la tuberculosis), obstetricia, CRED, ESNI (Estrategia nacional de inmunizaciones) y adulto mayor, además de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, se resuelven las necesidades más frecuentes y básicas que puede tener la población.

El horario de atención del Centro de Salud Zárate es de: lunes a sábado (sin contar feriados) de 8am hasta las 8pm, lo que significa que existe turno mañana y tarde.

4.4. Población, Muestra y Muestreo

4.4.1. Población

La población estuvo conformada por 162 madres que asistieron con sus niños y niñas al Centro de Salud Zárate, al servicio de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano (CRED).

4.4.1.1. Criterios de inclusión

- Madres que tengan niños y niñas que se encuentren entre los 0 a 6 meses de edad
- Madres mayores de 18 años
- Madres que hablen español
- Madres que sepan escribir y leer
- Madres con capacidad de respuesta oral

4.4.1.2. Criterios de exclusión

- Madres que no hablen español
- Madres que no sepan escribir ni leer
- Madres con alguna discapacidad mental o comunicativa

4.4.2. Muestra y muestreo

Para seleccionar la muestra se aplicó la fórmula para poblaciones finitas resultando 114 madres, y a través de un muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple, el cual garantiza que todos los sujetos de la población en estudio tengan la misma oportunidad de participar, ya que la selección es de forma independiente, y a pesar de no plasmar una población completa y perfecta, maximiza la expectativa de una muestra representativa que permite utilizar la estadística inferencial cuando se analizan los datos. ⁽⁶³⁾

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se utilizó la técnica encuesta y el instrumento cuestionario, elaborado por la investigadora. Consta de cuatro partes: presentación, instrucciones, datos generales (de la madre y del niño) y datos específicos, dentro del último se abarcaron ambas dimensiones: aspectos generales y técnica de amamantamiento. Se consideraron 20 preguntas de opción múltiple, de las cuales 2 de ellas con imágenes en las alternativas.

Por cada respuesta correcta se obtiene 1 punto, mientras que por cada incorrecta se obtiene 0, teniendo como puntaje final un rango de 0 a 20. Con el valor final alto, medio y bajo.

4.5.1. Validez

El cuestionario fue sometido a validez de contenido según Hernández – Nieto, que permitió que los jueces expertos valoraran cada ítem, estuvo conformado por 4 profesionales especialistas en el tema de investigación, para revisar el constructo y contenido del instrumento. Entre ellos se encuentran 2 metodólogos, 1 especialista en pediatría y 1 en neonatología.

Dichos resultados fueron validados a través del Coeficiente de Validez de Contenido, donde se obtuvo como resultado 0,8797 lo que se considera como bueno, y esto indica que el instrumento es aplicable.

4.6. Procedimientos de recolección y procesamiento de datos

En primer lugar, se solicitó a la directora de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos una carta de presentación dirigida a la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro, ya que era uno de los requisitos para ingresar al proceso que permitió la aplicación en el Centro de Salud Zárate.

Luego de que se completó con todos los requisitos que solicitó la DIRIS Lima Centro y se pasaran los filtros, se logró obtener el permiso. Este fue enviado de forma electrónica vía e-mail a la Médico jefe del Centro de Salud Zárate,

en donde se brindó la información sobre el periodo de tiempo, el tema y el objetivo de la investigación.

Después, se realizó las coordinaciones con la jefa médico y la enfermera encargada del área de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano (CRED), para empezar con la aplicación.

Se realizó la aplicación del instrumento los días útiles entre el mes de julio y agosto del 2024, en donde se le informó a cada una de las madres encuestadas el objetivo de la investigación con previo consentimiento informado, que garantizó la anonimidad y confidencialidad, lo cual aseguró que sus respuestas no fueran manipuladas ni distorsionadas. La recolección de datos se realizó durante 7 semanas, yendo 3 veces a la semana y manteniendo una comunicación efectiva con cada una de las madres encuestadas. Además, el tiempo de aplicación del instrumento por cada madre fue de 10 a 12 minutos aproximadamente.

Al finalizar con la recolección de datos, estos fueron procesados a través del programa estadístico Microsoft Excel 2021, siendo codificados de acuerdo a la tabla de códigos elaborada previamente, y posteriormente se colocaron en una matriz de datos mediante tablas y gráficos.

Para el procesamiento de datos se aplicó la escala de máximos y mínimos para el total: alto (14 – 20), medio (07 – 13) y bajo (0 – 06); y para las dimensiones, aspectos generales: alto (07 – 09), medio (04 – 06), bajo (0 – 03), técnica de amamantamiento: alto (08 – 11), medio (04 – 07), bajo (0 – 03).

4.7. Análisis estadístico

Se aplicó la estadística descriptiva que permitió el análisis y la presentación de los resultados obtenidos de forma significativa, sintetizada y entendible, mediante el programa Excel, a través de gráficos, tablas, en porcentajes y

frecuencias, que facilitó la interpretación de los datos en relación a los objetivos general y específicos.

4.8. Consideraciones éticas

Se aplicó y se tuvo en cuenta los principios bioéticos:

- Para la autonomía, se brindó una explicación sencilla y clara del objetivo de la investigación y se utilizó el consentimiento informado previo, que reflejó la participación voluntaria, la confidencialidad y el anonimato. ⁽⁶⁴⁾
- Beneficencia, facilitó a las madres la oportunidad de medir sus conocimientos generando mayor interés en el tema ⁽⁶⁴⁾, y brindó al Centro de Salud Zárate buena información mediante los resultados para que puedan mejorar su calidad de atención y educación.
- Justicia, donde todas las madres encuestadas tuvieron el mismo trato e información sobre el estudio. ⁽⁶⁴⁾

CAPÍTULO V: RESULTADOS

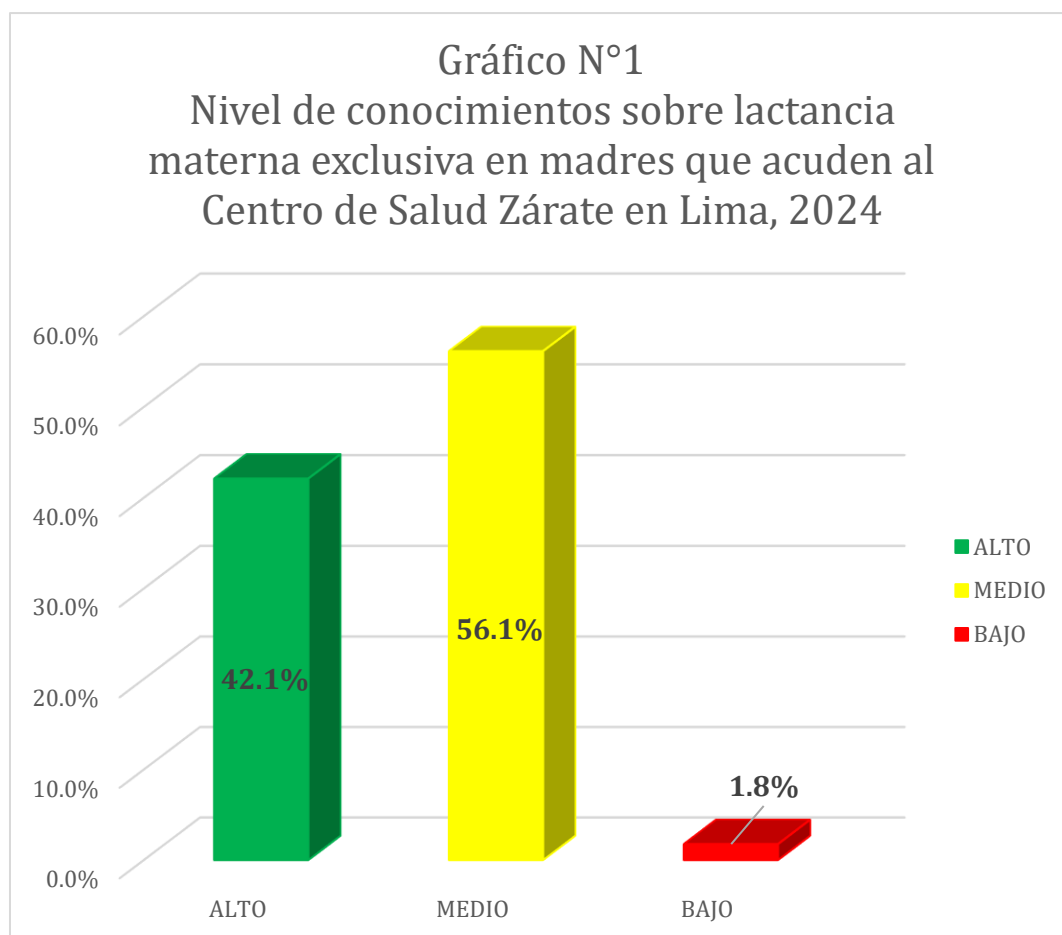
5.1. Presentación de tablas y/o gráficos y descripción de resultados

A continuación, se presentan los resultados de la investigación:

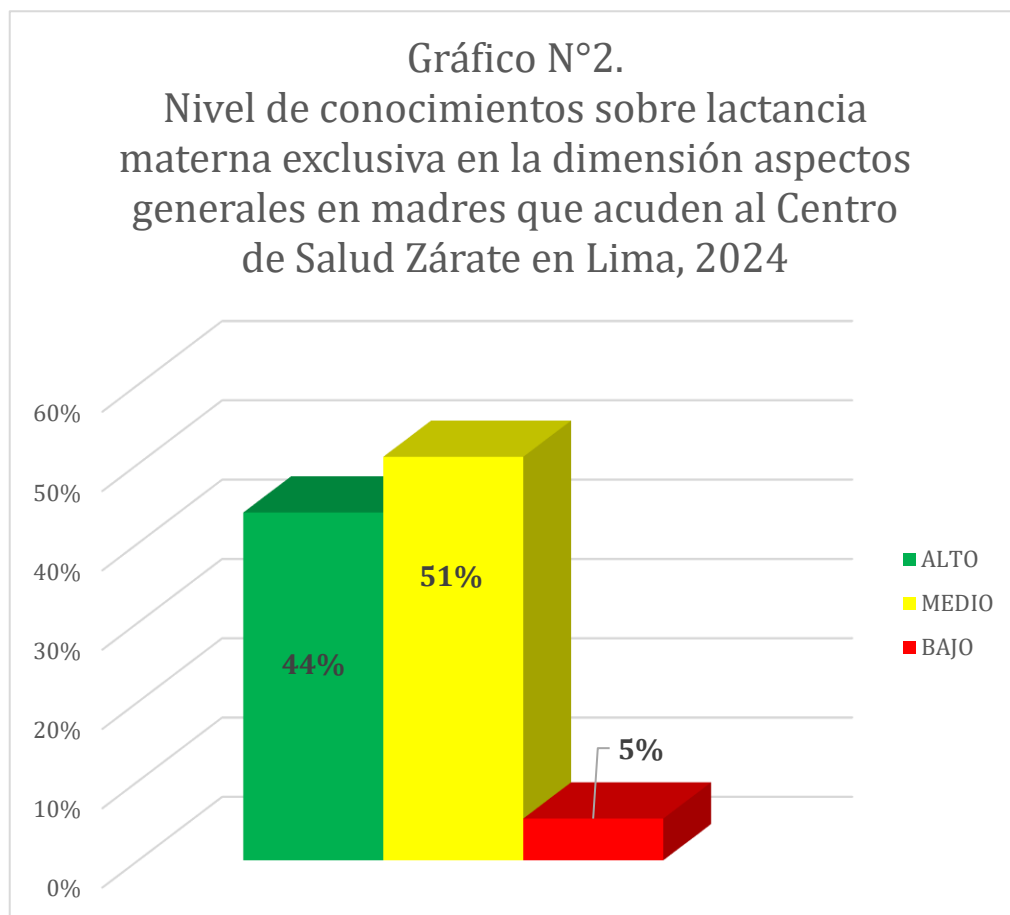
5.1.1. Datos generales

Del total de madres encuestadas 114 (100%); en relación a la edad, el 34% (39) están entre 24 a 29 años, el 28% (32) de 30 a 35 años, el 19% (22) de 18 a 23 años y el 18% (21) de 36 a más años. En grado de instrucción, el 50% (57) nivel secundario, 23% (26) con estudios técnicos, 19% (22) universitaria, 8% (9) primaria y el 0% ningún grado educativo; estado civil, 49% (56) conviviente, 32% (36) soltera, 19% (22) casada y 0% viuda y divorciada. En ocupación, 68% (77) es ama de casa y 32% (37) labora fuera de casa; el N° de hijos en total, 46% (53) tiene uno, 37% (42) dos, 13% (15) tres y 4% (4) cuatro o más. (Ver Anexo H)

5.1.2. Datos específicos

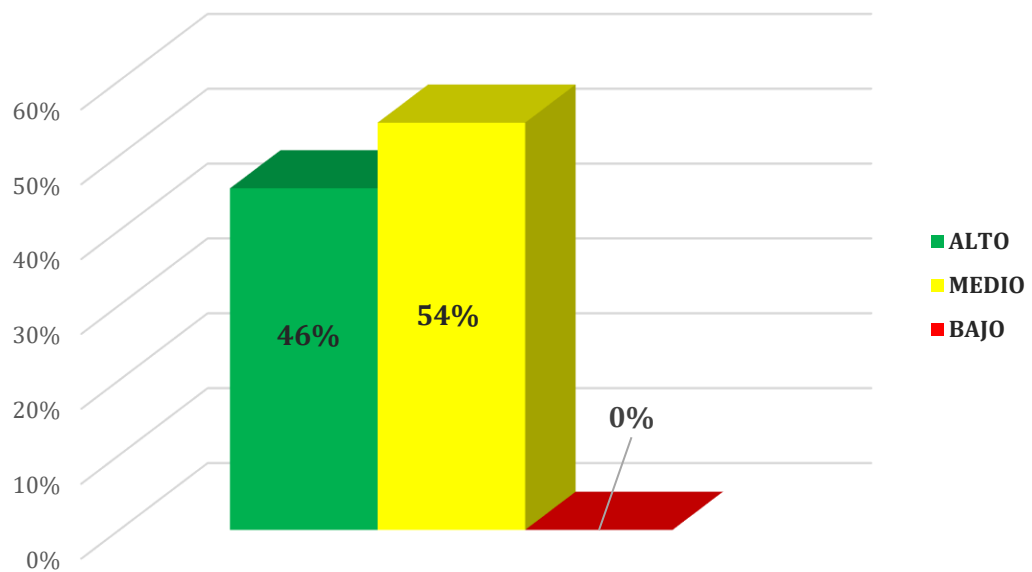


En el gráfico N°1, se muestra el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva que las madres encuestadas obtienen; de un total de 114 (100%), el 56,1% (64) fue medio, 42,1% (48) alto y 1,8% (2) bajo.



En el gráfico N°2, se observa el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en la dimensión aspectos generales que las madres refirieron; del 100% (114), el 51% (58) fue medio, 44% (50) alto y 5% (6) bajo. Teniendo en cuenta los indicadores, inicio temprano de la lactancia materna y beneficios, se resalta que los ítems N°4 y N°9 tuvieron respuestas incorrectas en 50% (57) y 49% (56), respectivamente. (Ver Anexo de la Tabla N°3)

Gráfico N°3.
Nivel de conocimientos sobre lactancia
materna exclusiva en la dimensión técnica de
amamantamiento en madres que acuden al
Centro de Salud Zárate en Lima, 2024



En el gráfico N°3, se indica el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en la dimensión técnica de amamantamiento que las madres demostraron; del total 100% (114), el 54% (62) medio, 46% (52) alto y 0% (0) bajo. Teniendo en cuenta los indicadores, posición de la madre y signos de una buena succión, se destaca que los ítems N°13 y N°17 presentaron respuestas incorrectas en 54% (62). (Ver anexo de la tabla N°4)

CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN

La lactancia materna exclusiva es una práctica que se viene realizando desde épocas antiquísimas debido a los beneficios a favor de la salud del niño y niña, desde que nace hasta que cumple 6 meses de vida; siendo la leche materna el único alimento que su estómago puede ingerir. ⁽¹⁾ Según la OMS, mientras más niños sean amamantados de forma exclusiva, mejor provecho habrá en su desarrollo y crecimiento. ⁽⁴⁾ Incluso, la UNICEF menciona que a mayor sea el retraso al recibir leche materna dentro de la primera hora de vida, se incrementa la tasa de mortalidad en lactantes, la cual tienes cifras que abarcan casi la mitad de la población recién nacida. ⁽⁷⁾

Hallazgos del estudio muestran que las madres poseen un nivel de conocimiento medio en lactancia materna exclusiva, seguido de alto; y un mínimo porcentaje bajo. Esto significa que las madres aún no comprenden totalmente la información sobre el tema, lo que podría brindar al niño una menor probabilidad de recibir conscientemente leche materna de forma directa y exclusiva. ⁽²⁾ Estudios similares fueron los de Arcentales J. ⁽²⁰⁾ donde evidencia que la mayoría de madres tienen un conocimiento medio, al igual que el estudio de Marroquín F., et al ⁽¹⁵⁾ y Palomino N. ⁽²⁴⁾, que más de la mitad de la población obtuvo medio. Estudios que difieren fueron de Vásquez P. ⁽²⁶⁾ con un porcentaje mayor en nivel alto, y el de Bocanegra J. y Calderón G. ⁽²⁵⁾, con un nivel bajo. De esta manera, este hallazgo es una señal para el profesional de enfermería sobre lo primordial que son las intervenciones educativas durante el periodo de lactancia materna exclusiva e incluso en la etapa de gestación, ya que se refuerzan los conocimientos y se corrige información errada, fomentando una mayor concientización al amamantar; con ello, el lactante gozaría de todos los beneficios que la leche materna ofrece satisfaciendo sus necesidades nutricionales, y promoviendo un crecimiento saludable.

En relación a la dimensión aspectos generales, se observa que un poco más de la mitad de la muestra tiene un nivel de conocimiento medio en lactancia materna exclusiva; dos quintos alto, y un mínimo porcentaje bajo. Esta dimensión comprende elementos básicos que la madre conoce en su definición, inicio temprano, importancia, tipos de leche materna y beneficios; sin embargo, algunos ítems evidencian la necesidad de fortalecer los conocimientos como: la importancia del calostro y los beneficios que brinda a la familia, cuyas respuestas incorrectas fueron la mitad en ambos. Investigaciones similares fue el de Palomino N. ⁽²⁴⁾, en concepto general que alcanzó un conocimiento medio, el de Marquina P. ⁽²⁷⁾, que casi los tres quintos fue medio. Sin embargo, no se encontraron estudios que difieran. Los hallazgos precisan que la relación interpersonal y comunicativa entre la madre y el profesional de enfermería es importante, ya que ellas aún tienen cierto temor o vergüenza sobre las dudas o preocupaciones que florecen durante la maternidad; o también, porque con anterioridad no han recibido una buena atención que les haya transmitido tranquilidad y empuje para aclarar algún interrogante con respecto al tema. Por tal motivo, existe la necesidad de cultivar un lazo positivo entre ambas partes para generar seguridad, comprensión y paciencia, que contribuya al aprendizaje constante y eficaz de la madre. Por ello se debe fortalecer los conceptos básicos mediante afiches, volantes y folletos informativos, de manera creativa, claros y sencillos para el público objetivo.

En cuanto a la dimensión técnica de amamantamiento, abarca la medida higiénica, posición adecuada de la madre, del niño o niña, agarre y succión correcta, y frecuencia de mamadas, y se observa que cerca de los tres quintos presentan un nivel de conocimiento medio en lactancia materna exclusiva y en menor proporción un nivel alto. No obstante, ciertos ítems reflejan la urgencia de reforzar los conocimientos en: posición de la madre y signos de una buena succión, cuyas respuestas incorrectas fueron en ambas más de la mitad de la muestra. Esto demuestra que la posición que opta la madre cuando da de lactar está siendo inadecuada, afectando la

succión y el buen agarre por parte del niño, y simultáneamente dañando el seno materno ⁽⁴⁶⁾. Ello concuerda con los resultados del estudio de García LA. ⁽³⁰⁾, que más de la mitad de su muestra obtuvo un nivel medio, refiriendo que la adopción de una postura adecuada en la madre junto a un buen acoplamiento del lactante es un momento de satisfacción para ambos. A diferencia del estudio realizado por Bocanegra J. & Calderón G. ⁽²⁵⁾, que alcanzaron un nivel bajo. En otras palabras, se resalta la importancia de educar sobre las características relacionadas a una técnica adecuada de lactancia, pues afecta negativamente el desarrollo saludable del lactante cuando no hay buen agarre y/o succión, causando problemas gastrointestinales como la acumulación de gases y el estreñimiento, que genera dolor e irritación, además de una pobre ganancia de peso; por otro lado, en el seno materno se forman heridas o grietas que genera mucho dolor y sangrado, que podría obstruir los conductos lactíferos ⁽¹⁸⁾. Por ende, todo ello puede llevar a la madre a tomar decisiones difíciles como destetar temporal o definitivamente y así optar por brindar otro tipo de alimentación en base a fórmulas lácteas.

Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos también podrían existir aspectos sociodemográficos, que comprenden edad, grado de instrucción, estado civil, ocupación y cantidad de hijos. Cabe recalcar que dos de ellos, podrían influir en el nivel de conocimiento que poseen las madres, ya que la mayoría tuvo un nivel de instrucción secundario y solo cuentan con un solo hijo, por lo que según la teoría de Ramona Mercer ⁽⁵⁴⁾, una mujer se convierte en madre y atraviesa un proceso evolutivo, pero difícil, para lo cual se adquiere nuevos conocimientos en el rol que le corresponde; no obstante, la falta de experiencia en la maternidad podría generar una falta de conocimiento.

Por otro lado, en los establecimientos de primer nivel de atención se podrían implementar lugares ambientados y adecuados para brindar una mejor asesoría educativa. En este sentido, el profesional de enfermería

lograría intervenciones educativas efectivas dando mayor comodidad a las madres y centrándose en los temas más sustanciales sobre lactancia materna exclusiva como: importancia, beneficios a corto y largo plazo, técnica y posición adecuada de lactancia, y consecuencias de un mal agarre y/o succión. De ahí la importancia de los aportes del profesional de enfermería en la comunidad materna e infantil, ya que debe estar enfocada en el bienestar físico, mental y emocional de ambos grupos poblacionales, identificando necesidades, carencias y limitaciones, y siendo un pilar clave para fortalecer la promoción de la lactancia materna exclusiva, en donde se incluya al entorno familiar, que es la red de apoyo más significativa que requiere una mujer en esta nueva etapa. Por tanto, la enfermera es la encargada de orientar de forma oral, escrita, pero sobre todo demostrativa al educar a la madre sobre los pasos correctos de una técnica adecuada según la normativa técnica actualizada.

Por esta razón, se debe incentivar la participación de la madre y el padre, ya que ambos en conjunto tienen la responsabilidad y el compromiso de cuidar y velar por la salud de sus hijos, de esta forma la madre sentirá una gran red de apoyo durante el periodo de lactancia, la cual puede generar frustración e irritación. Por tal motivo, se debe continuar elaborando investigaciones en base al tema planteado y apoyar al personal de enfermería a crear talleres, programas y charlas que sensibilicen a las madres para sigan realizando lactancia materna exclusiva.

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

- El nivel de conocimientos en lactancia materna exclusiva de las madres, en su mayoría es medio, significa que aún se continúe realizando intervenciones educativas, ya que podría perjudicar en un futuro la salud de los lactantes.
- Los conocimientos en aspectos generales de la lactancia materna exclusiva, en su mayoría fue nivel medio, esto muestra que las madres desconocen parcialmente la importancia y lo beneficioso que es amamantar a su niño, lo que afectaría en un futuro el crecimiento y desarrollo.
- La técnica de amamantamiento sobre lactancia materna exclusiva en su mayoría fue de nivel medio, lo que estaría desfavoreciendo la continuidad temporal o permanente de una lactancia materna exclusiva disminuyendo sus beneficios a corto y a largo plazo, y aumentando las cifras de mortalidad de este grupo etario.
- En los datos sociodemográficos de las madres de niños, en su mayoría tienen un grado de instrucción secundario y solo cuentan con un hijo, por lo que la inexperiencia y la falta de información científica podría influenciar notablemente en un conocimiento bueno.

7.2. Recomendaciones

- Al equipo de gestión del centro de salud, se apoyen la implementación de campañas y estrategias educativas que fomenten la importancia y los beneficios sobre lactancia materna exclusiva; así como, desarrollar paneles informativos e ilustrativos para despertar el interés de las madres.
- Al profesional de enfermería, continuar con el desempeño de su rol promocional fortaleciendo la práctica adecuada de la lactancia materna exclusiva, e indicando y advirtiendo las consecuencias que sufriría un niño al no ser amamantando.
- A los gestores públicos del sistema de salud, fortificar todos los centros de salud del primer nivel de atención, mediante la creación de grupos y ambientes en donde se brinde consejerías educativas a mujeres gestantes y a madres primerizas, teniendo en cuenta y respeto hacia sus costumbres socioculturales.
- A los estudiantes universitarios, desarrollar investigaciones de diseño correlacional como el nivel de conocimientos y prácticas de la lactancia materna exclusiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Gamboa, Eduardo Hernández. "Genealogía histórica de la lactancia materna." Revista enfermería actual en Costa Rica 15 (2008): 1
2. Salazar Scarlet, Chávez Mervin, Delgado Xiomara, Eudis Rubio Tamara Pacheco. Amamantamiento. Arco Venez Puer Ped [Internet]. diciembre de 2009 [citado el 1 de junio de 2022]; 72 (4): 163-166. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06492009000400010&lng=en.
3. Rosabal Suárez Laritza, Piedra Cosme Belkis. Intervención de enfermería para la capacitación sobre lactancia materna. Rev Cubana Enfermer [Internet]. 2004 Abr [citado 2022 Mayo 25] ; 20(1): 1-1. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192004000100002&lng=es.
4. Organización Mundial de la Salud. Alimentación del lactante y del niño pequeño. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding> (Último acceso 25 de mayo del 2022).
5. Lactancia materna y alimentación complementaria [Internet]. OPS.org. [citado el 25 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/lactancia-materna-alimentacion-complementaria>
6. Sólo 4 de cada 10 bebés menores de 6 meses son exclusivamente amamantados en América Latina y el Caribe [Internet]. Unicef.org. [citado el 4 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/solo-4-cada-10-bebes-menores-6-meses-exclusivamente-amamantados-america-latina-caribe>
7. UNICEF. Lactancia Materna. <https://www.unicef.org/mexico/lactancia-materna> (Último acceso 25 de mayo del 2023).

8. Más del 50% de niños y niñas recién nacidos de todo el mundo no reciben lactancia, lo que incrementa su posibilidad de padecer malnutrición [Internet]. Unicef.org. [citado el 4 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/situacion-lactancia-materna-ninos-recien-nacidos-problemas-malnutricion-anemia-obesidad-sobrepeso>
9. INEI. Encuesta demográfica y de Salud Familiar. Perú: Lima; 2022. Gob.pe. [citado el 4 de diciembre de 2023]. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1898/libro.pdf
10. López de Aberasturi Ibáñez de Garayo Ayala, Santos Ibáñez Nerea, Ramos Castro Yolanda, García Franco María, Artola Gutiérrez Carmen, Arara Vidal Isabel. Prevalencia y determinantes de la lactancia materna: estudio de Zorrotzaurre. Nutrir hospital [Internet]. febrero de 2021 [consultado el 8 de febrero de 2024]; 38(1): 50-59. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112021000100050&lng=es
11. Gonzales Aníbal Oblitas, Ortiz José Uberli, Herrera, Cruz Yohana Liseth Flores. Lactancia materna exclusiva en América Latina: una revisión sistemática. ¡Viva el Rev. Salud [Internet]! diciembre de 2022 [consultado el 8 de febrero de 2024]; 5(15): 874-888. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2664-32432022000300874&lng=es
12. Marroquín Ajpop, F., Pichiyá Barrios, S. P., & Pérez Meléndez, A. G. (2023). Conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres con atención del parto en el Hospital General Tipo I del municipio de Tecpán Guatemala, departamento de Chimaltenango, Guatemala. Septiembre–Octubre 2021. Disponible en: https://biblioteca.galileo.edu/tesario/bitstream/123456789/1451/1/2021-T-len-007-marroquin_pichiya_perez.pdf
13. Albán Pino PI, Yépez Fasce MB. Conocimientos, actitudes y prácticas en lactancia materna de las madres que asisten a los centros de salud

n°1, centro de salud n°4, Obrero Independiente y El Placer en la ciudad de Quito en el año 2015. PUCE; 2016.

14. Obregón, J. Conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva de las madres primíparas en un centro materno infantil de Lima, 2018 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Enfermería; 2019.
15. Velásquez, M. Conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres de lactantes menores de 6 meses que acuden a un centro de salud de Lima, 2018 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Enfermería; 2019
16. Rita, Bautista-Hualpa Y. y Díaz-Rivadeneira I. Conocimientos y prácticas de lactancia materna en madres adolescentes que asisten al Centro de Salud de Bagua. Rev Enferm. Herediana 10.1 (2017): 14-21. Disponible en: https://faenf.cayetano.edu.pe/images/2017/revistavol_10/enero_junio/conocimiento_insulina.pdf
17. Vignolo Julio, Vacarezza Mariela, Álvarez Cecilia, Sosa Alicia. Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. Arch. Med Int [Internet]. 2011 Abr [citado 2023 Oct 21] ; 33(1): 7-11. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003&lng=es.
18. MINSA. Guía técnica para la consejería en lactancia materna. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Promoción de la Salud. Lima: Ministerio de Salud; 2017. 54 p.
19. Revista Peruana de Investigación Materno Perinatal. Alvarez M, Angeles AP, Pantoja LR. Conocimientos sobre lactancia materna en madres primerizas. Rev Peru Investig Matern Perinat 2020; 9(4):10-15.
20. Arcentales J. Nivel de Conocimiento sobre Lactancia Materna Exclusiva en madres de Lactantes Hospitalizados, en el Hospital

Pediátrico Baca Ortiz, noviembre 2023. Tesis para optar el título profesional de Médico. Ecuador: Universidad Católica de Cuenca; 2023.

21. Mamani Y., Olivera V., Luizaga M., Illanes D. Conocimientos y prácticas sobre lactancia materna en Cochabamba-Bolivia: un estudio departamental. Gac Med Bolivia [Internet]. 2017 diciembre [citado 2022 agosto 02]; 40(2): 12-21. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-29662017000200004&lng=es.
22. Albán Pino PI, Yépez Fasce MB. Conocimientos, actitudes y prácticas en lactancia materna de las madres que asisten a los centros de salud n°1, centro de salud n°4, Obrero Independiente y El Placer en la ciudad de Quito en el año 2015. PUCE; 2016.
23. Berrocal, M., Flores, B. y Solano, O. Conocimiento y prácticas sobre la lactancia materna en madres adolescentes en el Centro de Salud "Chilca 2021". Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Enfermería, Escuela Académico Profesional de Enfermería, Universidad Continental, Huancayo, Perú.
24. Palomino N. Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en puérperas de 20 a 35 años en el Hospital Rezola Cañete, 2019. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Obstetricia, Escuela Académica Profesional de Obstetricia. Perú: Universidad Privada Sergio Bernales; 2019.
25. Bocanegra J., Calderón G. Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres primerizas del Hospital María Auxiliadora Rodríguez de Mendoza - Amazonas 2019 [Trabajo de investigación de segunda especialidad]. Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Facultad de Enfermería, Unidad de Posgrado; 2021.
26. Vásquez P. Conocimientos sobre Lactancia Materna Exclusiva en Madres de niños menores de seis meses. Centro de Salud Pachacútec, Cajamarca 2019. [Tesis para optar el título de licenciado]. Perú: Universidad Nacional de Cajamarca; 2019.

27. Marquina P. Nivel de conocimiento de las madres de menores de seis meses sobre lactancia materna exclusiva en servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Sergio E. Bernal en el periodo Noviembre – Diciembre, 2018. Lima: Universidad Nacional Federico Villarreal; 2019.
28. Velasquez C. Conocimiento y Práctica de lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses, Puesto de Salud Magdalena Nueva, Chimbote, 2017. Tesis para optar el título de segunda especialidad en Enfermería en Salud Pública con mención en Salud Familiar y Comunitaria. Perú: Universidad Inca Garcilaso de la Vega; 2017.
29. Baila Risco BMY, Quevedo Siesquén MM. Relación entre conocimientos y prácticas sobre lactancia materna en madres del programa de crecimiento y desarrollo Hospital Referencial Ferreñafe, 2016. Universidad Señor de Sipán; 2016.
30. García, LA. Nivel de conocimientos de las madres de niños menores de seis meses acerca de la lactancia materna exclusiva. Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo, Lima enero 2015. Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2015.
31. Organización Mundial de la Salud. Lactancia Materna. https://www.who.int/es/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1 (Último acceso 02 de agosto del 2023)
32. Anatomía y fisiología de la lactancia materna. Ocronos - Editorial Científico-Técnica [Internet]. 2019 [citado el 2 de agosto de 2022]; Disponible en: <https://revistamedica.com/anatomia-fisiologia-lactancia-materna/>
33. Society of Spanish Researches in the United Kingdom. Iglesias M. Lactancia materna: por qué y cómo. El punto de vista fisiológico. Diciembre 2019 (citado el 2 de agosto de 2022). Disponible en: <https://sruk.org.uk/es/lactancia-materna-por-que-y-como-el-punto-de-vista-fisiologico/#:~:text=La%20fisiolog%C3%ADa%20de%20la%20gl%C3>

[%A1ndula%20mamaria&text=El%20rol%20del%20beb%C3%A9%20e
s,trav%C3%A9s%20de%20los%20conductos%20lact%C3%ADferos.](#)

34. Anatomía de la mama - Lactancia sin dolor [Internet]. Lactancia sin dolor. 2019 [citado el 9 de agosto del 2022]. Disponible en: <https://www.lactanciasindolor.com/lactancia/lactancia-materna/anatomia-de-la-mama/>
35. Ayerra Adela, Zabau Jara, Adán Saray, Barricate. Anatomía y fisiología de la lactancia materna [Internet]. Ocronos - Editorial Científico-Técnica. Ocronos - Revista Médica y de Enfermería; 2019 [citado el 9 de agosto del 2022]. Disponible en: <https://revistamedica.com/anatomia-fisiologia-lactancia-materna/>
36. Anatomía de la mama [Internet]. Cirugiasdelamama. [citado el 9 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.cirugiasdelamama.com/anatomia-de-la-mama>
37. Sabillón F., Abdu B. Composición de la leche materna. Centro De Capacitación J, Materna L. Bvs.hn. [citado el 10 de agosto de 2022]. Disponible en: <http://www.bvs.hn/RHP/pdf/1997/pdf/Vol18-4-1997-7.pdf>
38. Ministerio de Salud y Protección Social. Páginas - Importancia de la lactancia materna [Internet]. Gov.co. [citado el 10 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PI/Paginas/ImportanciaLactanciaMaterna.aspx>
39. Verde Carmen Villarreal, Medina Maritza Dorila Placencia, Sifuentes Violeta Alicia Nolberto. Lactancia materna exclusiva y factores asociados en madres que acuden a establecimientos de salud de Lima Centro. Rdo. fac. Medicina. Tararear. [Internet]. Abril de 2020 [consultado el 30 de noviembre de 2023]; 20(2): 287-294. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-05312020000200287&lng=es

40. Lactancia materna [Internet]. Who.int. [citado el 30 de noviembre de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/health-topics/breastfeeding>
41. Componentes de la leche materna: ¿Qué contiene la leche materna? [Internet]. Medela. 2018 [citado el 9 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.medela.es/lactancia/viaje-de-las-madres/componentes-de-la-leche-materna#reference>
42. Mitchell C. OPS/OMS [Internet]. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. 2014 [citado el 10 de agosto de 2022]. Disponible en: https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9328:breastfeeding-benefits&Itemid=42403&lang=es
43. IMSS. Importancia de la lactancia materna [Internet]. Gob.mx. [citado el 10 de agosto de 2022]. <https://www.imss.gob.mx/maternidad2/eres-mama/lactancia-materna>
44. Salazar Scarlet, Chávez Mervin, Delgado Xiomara, Eudis Rubio Thamara Pacheco. lactancia materna Arco Venez Puer Ped [Internet]. 2009 Dic [citado 2022 Ago 02] ; 72(4): 163-166. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06492009000400010&lng=es.
45. MINSA. Más Salud. <http://bvs.minsa.gob.pe/massalud/MasSalud02.pdf> (Ultimo acceso 08 de agosto del 2022)
46. Urquiza R. Lactancia materna exclusiva: ¿siempre? Rvdo. Turquía ginecólogo obstetra [Internet]. abril de 2014 [citado el 8 de agosto de 2022]; 60(2): 171-176. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322014000200011&lng=es
47. UNICEF. Guía familiar de lactancia materna y alimentación complementaria [Internet]. Unicef.org. [citado el 10 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.unicef.org/panama/media/2636/file/LACTANCIA%20MATERNA%20GU%C3%8DA%20.pdf>

48. Técnicas de Lactancia Materna – AEP – Lactancia Materna [Internet]. AEP - Lactancia Materna. 2022 [citado el 9 de agosto de 2022]. Disponible en: <http://lactanciamaterna.aeped.es/tecnicas-de-lactancia-materna/>
49. Sitio Web “Acercando el IMSS al Ciudadano” [Internet]. Gob.mx. [citado el 10 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.imss.gob.mx/node/94951>
50. Organización Mundial de la Salud. La alimentación del lactante y del niño pequeño. Washington. Editorial OMS, OPS. 2010
51. Gestion.pe. [citado el 12 de septiembre de 2024]. Disponible en: https://gestion.pe/mundo/las-barreras-que-frenan-la-lactancia-materna-noticia/?gad_source=1&gclid=EAlaIQobChMIqeTMhoW8iAMV0kJIAB3-zSboEAMYASAAEgJgXfD_BwE
52. Estrada Rodríguez Janice, Amargós Ramírez Jaqueline, Reyes Domínguez Belkis, Guevara Basulto Ania. Intervención educativa sobre lactancia materna. AMC [Internet]. 2010 Abr [citado el 11 de septiembre de 2024] ; 14(2): . Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552010000200009&lng=es.
53. López-Sáleme R, Covilla-Pedrozo M, Morelo-Castro N, Morelos-Gaviria L. Factores culturales y sociales asociados a la lactancia materna exclusiva en San Basilio de Palenque. Duazary. 2019 mayo [citado el 11 de septiembre de 2024]; 16(2 número especial): 293 - 306. Disponible en: <https://doi.org/10.21676/2389783X.2961>
54. Estrada C. Cómo es la evolución y el desarrollo del bebé de 0 a 6 meses [Internet]. Guiainfantil.com. Guiainfantil.com; 2020 [citado el 9 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.guiainfantil.com/bebes/etapas/como-es-la-evolucion-y-el-desarrollo-del-bebe-de-0-a-6-meses/#header0>

55. Stanford Medicine Children's Health [Internet]. Stanfordchildrens.org. 2019 [citado el 9 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=newborn-reflexes-90-P05741#:~:text=Este%20reflejo%20se%20produce%20cuando,dura%20alrededor%20de%20cuatro%20meses>
56. ¿Qué rol cumple la enfermería en la promoción de la lactancia materna? [Internet]. Corporación Universitaria Iberoamericana. 2020 [citado el 9 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.ibero.edu.co/2020/08/06/que-rol-cumple-la-enfermeria-en-la-promocion-de-la-lactancia-materna/#:~:text=El%20papel%20que%20desempe%C3%B1a%20el,con%20alimentos%20hasta%20los%20dos>
57. Socienée.com. [citado el 11 de septiembre de 2024]. Disponible en: https://socienee.com/wp-content/uploads/n_nacionales/nn24.pdf
58. MINSA. Proyecto de Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal. Perú: Lima; 2024. [citado el 11 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6414069/5617451-resolucion-ministerial-n-372-2024-minsa.pdf>
59. Alvarado Laura, Guarín Luzmila, Cañón-Montañez Wilson. Adopción del rol maternal de la teórica Ramona Mercer al cuidado de enfermería binomio madre-hijo: reporte de caso en la Unidad Materno Infantil. RevCuid [Internet]. enero de 2011 [citado el 8 de agosto de 2022]; 2(1): 195-201. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-09732011000100015&lng=en.
60. Conocimiento [Internet]. Enciclopedia Significados. 2014 [citado el 14 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://www.significados.com/conocimiento/>
61. Porto JP. Niveles [Internet]. Definición.de. Definicion.de; 2008 [citado el 14 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://definicion.de/niveles/>

62. Columbié M., Morasen E., Daudinot B., Pría M., Moya Y., Couturejuzón L. Instrumento para explorar nivel de conocimientos sobre seguridad del paciente en estudiantes de pregrado. Educ Med Super [Internet]. 2016 Jun [citado 2024 Feb 19] ; 30(2). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412016000200009&lng=es.
63. Otzen Tamara, Manterola Carlos. Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. Int. J. Morphol. [Internet]. 2017 Mar [citado el 11 de setiembre del 2024] ; 35(1): 227-232. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022017000100037&lng=es)
64. Hernández R., Fernández C., Baptista M. Metodología de la investigación. [Internet]. México: Mac Graw Hill; 2014 [citado 12 de febrero del 2024]. Disponible en: https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
65. Koepsell D., Ruiz M. Ética de la investigación, Integridad Científica. 1º Edición. [Internet]. México: CONBIOÉTICA; 2015 [citado 12 de febrero del 2024]. Disponible en: https://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/Libro_Etica_de_la_Investigacion_gratuito.pdf

ANEXOS

- A. Operacionalización de la variable
- B. Cálculo de tamaño de muestra
- C. Instrumento
- D. Informe de juicios de expertos
- E. Libro de códigos
- F. Matriz de datos
- G. Consentimiento informado
- H. Tablas como anexos

ANEXO A: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE

Variable	Definición Conceptual	Dimensiones	Indicadores	Valor Final	Definición Operacional
Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva	Es la información personalizada y subjetiva sobre cuándo y cómo alimentar exclusivamente desde el seno de la madre al lactante, sin tener que introducir líquidos o comida sólida durante los primeros seis meses de vida; debido a que, en este periodo, la leche materna contiene todos los macro y micronutrientes necesarios que su organismo necesita para su crecimiento idóneo.	Aspectos generales	Definición de lactancia materna exclusiva	Alto Medio Bajo	Es el conjunto de ideas o de información que adquieren las madres que acuden al Centro de Salud de Zárate sobre la lactancia materna exclusiva con respecto a su importancia, duración (inicio y término), frecuencia, y sobre todo los beneficios que brinda en la salud del niño y niña, en la madre y también a la familia, lo cual será medido a través de un cuestionario que tiene como valor final alto, medio y bajo.
			Inicio temprano de la lactancia materna		
			Importancia de la lactancia materna exclusiva		
			Tipos de leche materna		
			Beneficios de lactancia materna exclusiva		
		Técnica de amamantamiento	Medida de higiene		
			Reflejo de búsqueda (señal) del bebé		
			Posición de la madre		
			Posición del bebé		
			Signos de un buen agarre		
			Signos de una buena succión		
			Signos de una mala succión y/o mal agarre		
			Duración y frecuencia de las mamadas		

ANEXO B: CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA

PARA ESTIMAR UNA PROPORCIÓN

$$n = \frac{(Z)^2 P Q N}{i^2 (N - 1) + Z^2 P Q}$$

Donde:

N: Tamaño de la población	162
Z: Grado de confianza que se establece	1.96
i: Error absoluto o precisión de la estimación de la proporción	0.05
P: Proporción de unidades que poseen el atributo de interés	0.5
Q: Resto aritmético de P	0.5

$$n = \frac{(1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5 \times 162}{(0.05)^2 \times (162 - 1) + (1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5}$$

$$n = \frac{3.8416 \times 0.25 \times 162}{(0.0025 \times 161) + (3.8416 \times 0.25)}$$

$$n = \frac{155.5848}{0.4025 + 0.9604}$$

$$n = \frac{155.5848}{1.3629}$$

$$n = 114.1571 = 114 \text{ madres}$$

ANEXO C: INSTRUMENTO

CUESTIONARIO

PRESENTACIÓN:

Estimada madre de familia, mi nombre es Sol Venus Rodríguez Vela, estudiante de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y estoy realizando un estudio de investigación titulado **“Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres de niños que acuden a un Centro de Salud de Lima, 2024”**, la cual permitirá brindar una mayor información sobre la realidad en la que se encuentran las madres actualmente, y de esa manera contribuir en el crecimiento y desarrollo óptimo de los lactantes. Por tal motivo, la invito a participar de este cuestionario que será de carácter anónimo y confidencial, solo para uso del estudio, por lo que solicito responda con total sinceridad. Se agradece de antemano su colaboración.

INSTRUCCIONES:

Realice la lectura de cada una de las preguntas y responda con letra clara o marque con un aspa (X) la alternativa que considere conveniente. Es importante que responda todas las preguntas, y si presenta alguna duda puede solicitar mi ayuda.

CONTENIDO:

A. DATOS GENERALES:

De la madre:

1. Edad: 18 – 23 años (A)
24 – 29 años (B)
30 – 35 años (C)
36 años – a más (D)

2. Grado de instrucción:

Ninguno (A) Primaria (B) Secundaria (C)
Técnica (D) Universitaria (E)

3. Estado Civil:

Casada (A) Soltera (B) Conviviente (C)
Viuda (D) Divorciada (E)

4. Ocupación: Ama de casa (A) Trabaja (B)

5. Número de hijos en total:

1 (A) 2 (B) 3 (C) 4 o más (D)

Del bebé:

1. Edad del niño:

- (A) 0 días a 1 mes
- (B) 1 mes 1 día a 2 meses
- (C) 2 meses 1 día a 3 meses
- (D) 3 meses 1 día a 4 meses
- (E) 4 meses 1 día a 5 meses
- (F) 5 meses 1 día a 6 meses

2. Sexo: Femenino (A) Masculino (B)

B. DATOS ESPECÍFICOS: A continuación, marque con un aspa (X) las respuestas a las siguientes preguntas que presentan opción múltiple, es importante que solo marque una sola alternativa.

1. La lactancia materna exclusiva consiste en darle al niño(a):

- a. Leche materna y papilla
- b. Leche materna y sopas
- c. Leche materna y agua
- d. Sólo leche materna

2. La lactancia materna exclusiva se brinda al niño(a) hasta los primeros:

- a. 2 meses de vida.
- b. 3 meses de vida.
- c. 6 meses de vida.
- d. 5 meses de vida.

3. La lactancia materna se inicia por primera vez:

- a. Después de 2 horas del nacimiento
- b. Durante la primera hora de vida
- c. Un día después del nacimiento
- d. Después de 3h del nacimiento

4. La primera leche producida por la madre es conocida como calostro, la cual ayuda al bebé en:

- a. La eliminación del meconio (primera deposición)
- b. Elevar el sistema inmunológico
- c. Que acepte más rápido la leche materna
- d. Generar un mayor vínculo con su madre

5. La lactancia materna exclusiva es importante porque:

- a. Es una de las formas para alimentar al niño(a) junto a la fórmula láctea
- b. Brinda los nutrientes esenciales y la hidratación necesaria para su desarrollo óptimo
- c. Lo alimenta por 1 año entero sin necesidad de brindar otros alimentos
- d. Lo ayuda sólo a su crecimiento físico

6. Los tipos de leche materna que existen son:

- a. Calostro y leche madura
- b. Leche de transición y leche madura
- c. Calostro y leche de transición
- d. Calostro, leche de transición y leche madura

7. Los beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva al niño(a) son:

- a. Favorece su adecuado crecimiento y desarrollo, y lo protege de enfermedades crónicas.
- b. Fortalece solo su sistema excretor y es gratis.
- c. Favorece el vínculo padre-hijo y reduce el riesgo de sufrir osteoporosis
- d. Duerme con más rapidez, más tiempo y permite a la madre realizar otras actividades.

8. Los beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva a la madre son:

- a. Ayuda en la recuperación después del parto y disminuye la posibilidad de contraer enfermedades crónicas no transmisibles
- b. Sirve como anticonceptivo natural y contribuye con la involución más rápida del útero
- c. Reduce la incidencia de hemorragias postparto y ayuda a la subida del peso corporal.
- d. Es gratis y ayuda a la prevención del cáncer de estómago.

9. Los beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva a la familia, además de ser económica, permite:

- a. Reducir el riesgo de padecer VIH.
- b. Su disponibilidad inmediata
- c. Disminuye la muerte de niños(as) menores de 2 años.
- d. No contaminar el medio ambiente.

10. Antes de dar de lactar, lo primero que usted tiene que hacer como medida higiénica es:

- a. Amarrarse el cabello
- b. Bañarse
- c. Cambiarse de ropa
- d. Lavarse las manos con agua y jabón

11. El reflejo de búsqueda se refiere cuando el niño(a):

- a. Lleva su mano a la boca
- b. Mueve la cabeza y abre la boca para buscar en dirección al seno de la madre
- c. Siente que se le toca la palma de la mano y la cierra inmediatamente
- d. Se ríe al tocarle suavemente las mejillas

12. Cuando se le da de lactar al niño, la madre debe coger su seno en forma de:

a)



b)



13. La posición que debe adoptar la madre al amamantar además de ser cómoda y relajada, debe colocar la cabeza del niño sobre:

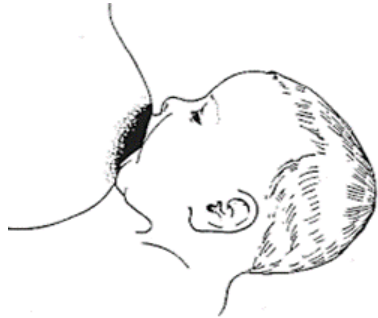
- a. La flexión de su codo
- b. El antebrazo
- c. Todo el brazo
- d. Las piernas

14. La posición que un niño(a) debe optar cuando es amamantado, además de estar pegado a la madre, debe coger con su boca:

- a. La mitad del pezón.
- b. El pezón y gran parte de la areola.
- c. La punta del pezón
- d. Toda la areola

15. Marque la imagen que usted considere que tiene un buen agarre del seno materno:

a)



b)



16. La succión del niño(a) es considerada adecuada, cuando las mamadas son:

- a. Lentas, profundas y con pausas cortas
- b. Rápidas, profundas y con pausas prolongadas
- c. Lentas, superficiales y con pausas prolongadas
- d. Rápidas, profundas y sin pausas

17. Una succión adecuada también se puede observar cuando el niño presenta:

- a. Mejillas tensas, mentón del bebé en el aire y labio inferior evertido
- b. Labio inferior evertido, mentón del bebé tocando el seno materno y boca media abierta
- c. Labio inferior evertido, mejillas redondeadas y boca bien abierta
- d. Mejillas redondeadas, mentón del bebé en el aire y labio inferior evertido

18. Cuando el niño no tiene un buen agarre, los senos de la madre pueden sufrir:

- a. Abultamiento de leche materna
- b. Raspones en todo el seno materno
- c. Grietas o heridas en el pezón
- d. Moretones alrededor del pezón
- e. Vaciamiento de leche materna

19. Se debe amamantar al niño(a) de cada: (rango de tiempo)

- a. 3 a 5 minutos
- b. 20 a 30 minutos
- c. 2 a 3 horas
- d. 5 a 6 horas

20. Se debe amamantar al niño(a) cada vez que: (situación o momento)

- a. Lloro
- b. Se despierta
- c. No hay momento determinado (libre demanda)
- d. Realiza un quejido

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN...!

ANEXO D: INFORME DE JUICIOS EXPERTOS

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC)

Item	J1	J2	J3	J4	Σ	Mx	CVCi	Pei	CVCic
1	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
2	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
3	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
4	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
5	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
6	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
7	4	4	5	3	16	4,0000	0,8000	0,0039	0,7961
8	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
9	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
10	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
11	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
12	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
13	3	4	5	5	17	4,2500	0,8500	0,0039	0,8461
14	4	4	5	4	17	4,2500	0,8500	0,0039	0,8461
15	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
16	4	4	5	4	17	4,2500	0,8500	0,0039	0,8461
17	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
18	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
19	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
20	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
								TOTAL	17,6719
								CVCt	0,88359375
								CVC tc	0,8797

INTERPRETACIÓN DEL CÁLCULO DEL CVC

Valor del CVC	Interpretación de la validez y concordancia
De 0 a 0,60	Inaceptable
Mayor a 0,60 y menor o igual a 0,70	Deficiente
Mayor a 0,70 y menor o igual a 0,80	Aceptable
Mayor a 0,80 y menor o igual a 0,90	Buena
Mayor a 0,90	Excelente

Fuente: Hernández-Nieto (2011)

Interpretación: Se encuentra entre 0.80 y 0.90, lo que es considerado como buena, por lo que el instrumento es válido para aplicación.

ANEXO E: LIBRO DE CÓDIGOS

DATOS GENERALES

De la madre:

CRITERIO	CATEGORÍA	CÓDIGO
1. Edad	18 – 23 años	A
	24 – 29 años	B
	30 – 35 años	C
	36 – a más años	D
2. Grado de instrucción	Ninguno	A
	Primaria	B
	Secundaria	C
	Técnica	D
	Universitaria	E
3. Estado Civil	Casada	A
	Soltera	B
	Conviviente	C
	Viuda	D
	Divorciada	E
4. Ocupación	Ama de casa	A
	Otros	B
5. N° de hijos en total	Uno	A
	Dos	B
	Tres	C
	Cuatro o más	D

Del niño(a):

CRITERIO	CATEGORÍA	CÓDIGO
1. Edad	0 a 1 mes	A
	1 mes 1 día a 2 meses	B
	2 meses 1 día a 3 meses	C
	3 meses 1 día a 4 meses	D
	4 meses 1 día a 5 meses	E
	5 meses 1 día a 6 meses	F
2. Sexo	Femenino	A
	Masculino	B

DATOS ESPECÍFICOS

VALOR O CATEGORÍA	CÓDIGO
Respuesta correcta	1
Respuesta incorrecta	0

Nº de ÍTEM	Clave	Puntaje
1	d	1
2	c	1
3	b	1
4	b	1
5	b	1
6	d	1
7	a	1
8	a	1
9	b	1
10	d	1
11	b	1
12	b	1
13	a	1
14	b	1
15	a	1
16	a	1
17	c	1
18	c	1
19	c	1
20	c	1

ANEXO F: MATRIZ DE DATOS

SUJETOS	DATOS GENERALES							DATOS ESPECÍFICOS																						
	DE LA MADRE					DEL NIÑO(A)		ASPECTOS GENERALES										TÉCNICA DE AMAMANTAMIENTO												TOTAL
1	2	3	4	5	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUBTOTAL	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	SUBTOTAL		
1	D	C	C	B	B	F	B	1	1	1	0	1	0	1	0	1	6	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	7	13
2	A	C	C	B	B	E	B	0	1	0	0	1	1	1	0	1	5	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	6	11
3	B	D	B	B	B	C	A	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7	10
4	D	C	B	A	C	C	A	1	1	0	0	1	1	1	0	1	6	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	7	13
5	C	D	C	A	B	E	B	1	0	1	0	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	9	16
6	D	C	C	B	C	F	A	1	1	1	1	1	0	1	1	0	7	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	5	12
7	A	D	B	A	A	F	A	1	0	1	1	1	1	1	1	0	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	18
8	C	C	C	B	A	F	B	0	1	1	1	1	0	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	18
9	C	B	A	A	B	B	B	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	9	17
10	B	C	C	A	B	D	A	1	1	1	0	1	1	1	0	0	6	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	7	13
11	C	C	A	A	B	A	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	7	16
12	B	C	A	A	B	A	B	1	0	1	1	1	1	1	1	0	7	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	9	16
13	C	C	C	A	A	D	B	1	1	1	0	1	0	1	1	0	6	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	6	12
14	B	C	C	A	A	D	A	1	1	1	0	1	1	1	1	0	7	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	7	14
15	D	D	A	A	B	A	A	1	1	0	1	1	1	1	1	0	7	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	5	12
16	A	C	C	A	A	D	A	1	1	0	1	0	0	1	1	1	6	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	5	11
17	B	E	C	B	A	F	B	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	9	17
18	C	C	B	A	D	B	A	1	1	1	1	0	1	1	1	1	8	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	5	13
19	C	E	A	B	B	B	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	9	18
20	D	C	C	A	C	A	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	8	17

21	D	C	B	A	D	F	B	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	8	11
22	C	D	C	B	B	F	B	1	1	1	0	1	0	1	1	1	7	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	9	16
23	D	E	B	A	A	F	B	0	0	0	1	1	0	1	0	1	4	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	7	11
24	D	B	C	A	C	E	B	1	1	0	0	1	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	8
25	C	D	C	B	A	F	B	0	0	1	1	1	1	1	1	0	6	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	10	16
26	A	C	C	A	B	A	A	1	1	1	1	1	1	1	0	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	18
27	D	B	B	A	C	A	A	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	5	13
28	C	D	B	A	D	E	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	7	13
29	D	C	C	A	C	C	A	1	1	1	0	1	1	1	0	1	7	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	10	17
30	B	E	C	A	B	A	B	1	1	0	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	19
31	C	D	C	A	A	D	B	1	1	0	0	1	1	1	1	0	6	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	7	13
32	A	C	B	B	A	F	A	0	0	1	0	1	1	1	1	0	5	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	7	12
33	A	C	C	A	A	C	A	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	6
34	A	C	C	A	A	A	B	1	1	0	1	1	1	1	1	0	7	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	7	14
35	B	C	C	B	A	F	A	0	0	1	0	0	1	1	1	1	5	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	8	13
36	C	C	A	A	B	F	B	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	7	13
37	C	D	C	B	B	A	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
38	B	C	C	A	B	E	A	1	1	1	1	1	0	1	1	0	7	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	6	13
39	A	C	C	A	A	F	A	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	8	12
40	B	D	C	A	B	C	B	1	1	1	0	1	1	1	1	0	7	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	6	13
41	B	E	B	B	A	B	A	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	18
42	B	C	A	A	B	D	A	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	18
43	A	B	C	A	B	F	B	0	0	1	1	0	1	0	0	1	4	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	8	12
44	A	B	B	A	A	C	A	1	1	1	0	1	0	1	1	1	7	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	6	13
45	C	E	C	A	B	A	A	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	9	17
46	C	E	A	B	A	F	B	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	8	11
47	B	C	C	A	A	D	B	0	0	1	0	1	0	1	1	1	5	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	7	12

48	A	B	B	A	A	F	B	1	1	1	0	1	0	1	0	0	5	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	6	11
49	D	D	A	A	D	A	A	1	1	1	1	1	1	1	0	1	8	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	7	15
50	D	D	C	B	B	F	B	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	6	10
51	C	D	B	A	B	E	A	0	0	1	1	1	0	1	1	1	6	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	7	13
52	B	C	A	A	C	E	A	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	9	13
53	B	C	A	A	C	D	A	1	1	1	0	1	0	1	0	0	5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	7	12
54	A	C	C	A	A	F	A	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	8	16
55	A	E	A	A	A	F	A	1	0	1	0	1	1	1	1	1	7	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	5	12
56	B	C	B	B	A	F	A	0	1	1	1	1	0	1	1	0	6	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	7	13
57	C	D	C	A	B	A	B	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	9	17
58	B	D	C	A	A	F	B	0	0	1	1	1	1	1	0	1	6	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	7	13
59	C	E	C	B	A	F	B	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	18
60	B	D	A	A	B	C	A	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	19
61	B	E	C	A	A	F	A	1	0	1	1	1	0	1	1	0	6	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	5	11
62	B	D	B	B	A	F	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	9	18
63	B	E	B	B	B	C	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	9	18
64	A	C	B	A	A	A	B	1	1	1	0	1	1	1	1	1	8	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	7	15
65	B	B	B	A	A	E	B	1	1	1	0	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	8	16
66	B	D	C	B	A	F	A	1	0	1	0	1	1	1	1	1	7	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9	16
67	A	B	B	A	A	E	A	0	0	1	0	1	0	1	1	0	4	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	7	11
68	A	B	B	A	A	D	A	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	7	12
69	C	D	B	B	A	F	B	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	7	15
70	B	C	C	A	A	F	B	1	1	1	0	1	0	0	1	0	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10	15
71	C	E	B	B	A	E	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	9	18
72	C	C	C	B	A	F	B	1	1	0	0	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	18
73	D	E	A	B	B	D	A	0	0	1	0	1	1	1	1	1	6	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	6	12
74	D	E	A	B	B	C	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	9	18

75	A	C	C	A	A	B	B	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	9	16
76	B	C	B	B	A	D	B	1	1	1	0	1	1	1	0	0	6	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	7	13
77	C	D	C	B	B	E	B	1	1	0	0	1	0	1	1	0	5	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	7	12
78	B	C	A	A	A	E	B	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	8	16
79	B	C	C	B	A	F	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	6	15
80	D	D	B	B	B	C	B	0	1	1	0	1	0	1	1	0	5	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	7	12
81	B	D	B	B	B	C	A	0	0	0	1	1	1	0	1	1	5	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	7	12
82	D	C	B	A	C	C	A	1	1	0	0	0	1	1	0	0	4	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	7	11
83	D	E	A	B	B	D	A	1	0	0	0	1	1	1	0	1	5	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	8	13
84	D	E	A	B	B	C	B	1	1	0	0	0	1	1	0	0	4	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	7	11
85	A	C	B	A	A	B	A	1	1	0	0	1	0	1	1	1	6	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	7	13
86	C	D	C	A	C	A	A	1	1	0	0	1	0	1	1	0	5	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	8	13
87	B	C	B	A	A	C	B	1	1	1	0	1	0	1	1	0	6	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	10
88	A	C	B	A	A	A	A	1	1	1	0	1	1	1	0	0	6	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9	15
89	B	E	C	B	A	B	A	1	1	1	0	0	1	1	1	1	7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	16
90	C	C	C	A	C	B	B	0	0	1	1	1	0	1	0	0	4	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	9	13
91	A	C	B	A	A	C	A	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4	6
92	B	D	C	A	B	A	A	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	7	10
93	C	C	C	A	B	C	B	0	1	1	0	1	1	1	0	1	6	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	7	13
94	A	D	B	A	A	B	A	0	1	1	1	0	0	1	1	0	5	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	7	12
95	C	C	B	A	C	E	A	1	0	1	0	1	1	0	1	0	5	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	8	13
96	B	C	A	A	B	C	A	1	1	0	0	1	0	1	1	1	6	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	7	13
97	A	E	C	B	A	A	B	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	10	18
98	C	C	B	A	C	D	B	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	7	11
99	B	D	C	A	A	E	A	1	0	1	1	1	0	1	1	0	6	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	6	12
100	C	C	C	A	C	B	B	0	1	0	0	1	0	1	0	1	4	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	7	11
101	B	E	B	B	A	C	B	1	1	1	1	0	0	1	1	1	7	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9	16

102	C	C	A	A	B	A	B	1	0	1	1	1	0	0	1	1	6	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	5	11
103	B	C	B	A	B	D	A	1	1	0	1	1	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	4	9
104	B	E	C	A	A	C	B	1	1	1	0	0	1	1	1	1	7	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	8	15
105	D	C	B	A	C	F	B	0	0	1	1	1	0	1	0	1	5	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	8	13
106	C	C	C	A	B	B	B	0	1	1	1	1	0	1	1	0	6	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	9	15
107	B	E	C	B	B	A	A	1	1	0	0	1	1	1	1	1	7	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	8	15
108	D	C	C	A	B	C	B	1	1	0	0	1	1	1	1	0	6	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	5	11
109	C	C	C	A	B	D	B	1	1	1	0	0	1	0	1	0	5	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9	14
110	B	C	A	A	A	B	A	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5	11
111	B	E	C	B	A	F	B	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	10	18
112	C	C	A	A	A	E	B	0	1	1	0	1	1	1	0	1	6	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8	14
113	D	C	C	A	B	C	A	1	1	1	0	1	0	1	1	0	6	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	7	13
114	B	C	C	A	A	D	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	7	13

ANEXO G: CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, por medio de la presente expreso libre y voluntariamente, sin ningún tipo de presión de por medio, que acepto participar en el proyecto de tesis titulado: **“Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres de niños que acuden a un Centro de Salud de Lima, 2024”**, conducido por Sol Venus Rodriguez Vela y autorizada por la Facultad de Medicina y Escuela de Enfermería, así como del respaldo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Además, que la realización del cuestionario tomará alrededor de 15min, y que si no aceptara mi participación nadie me tratará de manera diferente. Comprendo que mi participación es totalmente voluntaria, y que, si deseo, puedo retirarme en cualquier momento. Asimismo, se me ha explicado que las respuestas al cuestionario son de carácter confidencial y que nadie tendrá acceso a ellas, mis datos personales también se mantendrán confidenciales. Por otro lado, participar en el estudio no costará nada, ni recibiré ningún estipendio y que si tuviera alguna pregunta podré llamar a la responsable del estudio. He leído y entiendo este consentimiento informado.

Firma de la madre de familia

ANEXO H: TABLAS

Tabla N°1. Datos generales de las madres que acuden al
Centro de Salud Zárate. Lima - Perú, 2024

DATOS GENERALES		MADRES	
		N°	%
1. Edad	18 – 23 años	22	19%
	24 – 29 años	39	34%
	30 – 35 años	32	28%
	36 – a más años	21	18%
2. Grado de instrucción	Ninguno	0	0%
	Primaria	9	8%
	Secundaria	57	50%
	Técnica	26	23%
	Universitaria	22	19%
2. Estado Civil	Casada	22	19%
	Soltera	36	32%

	Conviviente	56	49%
	Viuda	0	0%
	Divorciada	0	0%
3. Ocupación	Ama de casa	77	68%
	Otros	37	32%
4. N° de hijos en total	Uno	53	46%
	Dos	42	37%
	Tres	15	13%
	Cuatro o más	4	4%

Tabla N°2. Edad y sexo de los niños y niñas de las madres que acuden al Centro de Salud Zárate. Lima - Perú, 2024

DATOS GENERALES		NIÑO(A)	
		N°	%
Edad	0 a 1 mes	19	17%
	1 mes 1 día a 2 meses	12	11%
	2 meses 1 día a 3 meses	21	18%
	3 meses 1 día a 4 meses	16	14%
	4 meses 1 día a 5 meses	15	13%
	5 meses 1 día a 6 meses	31	27%
Sexo	Femenino	56	49%
	Masculino	58	51%

Tabla N°3. Resultados por cada ítem en la Dimensión Aspectos Generales

N°	ÍTEM	CORRECTO		INCORRECTO	
		N°	%	N°	%
1	La lactancia materna exclusiva consiste en darle al niño(a):	84	74%	30	26%
2	La lactancia materna exclusiva se brinda al niño(a) hasta los primeros:	80	70%	34	30%
3	La lactancia materna se inicia por primera vez:	84	74%	30	26%
4	La primera leche producida por la madre es conocida como calostro, la cual ayuda al bebé en:	57	50%	57	50%
5	La lactancia materna exclusiva es importante porque:	97	85%	17	15%
6	Los tipos de leche materna que existen son:	63	55%	51	45%
7	Los beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva al niño(a) son:	105	92%	9	8%
8	Los beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva a la madre son:	81	71%	33	29%
9	Los beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva a la familia, además de ser económica, permite:	58	51%	56	49%

Tabla N°4. Resultados por cada ítem en la Dimensión Técnica Amamantamiento

N°	ÍTEM	CORRECTO		INCORRECTO	
		N°	%	N°	%
10	Antes de dar de lactar, lo primero que usted tiene que hacer como medida higiénica es:	91	80%	23	20%
11	El reflejo de búsqueda se refiere cuando el niño(a):	92	81%	22	19%
12	Cuando se le da de lactar al niño, la madre debe coger su seno en forma de:	88	77%	26	23%
13	La posición que debe adoptar la madre al amamantar además de ser cómoda y relajada, debe colocar la cabeza del niño sobre:	53	46%	61	54%
14	La posición que un niño(a) debe optar cuando es amamantado, además de estar pegado a la madre, debe coger con su boca:	61	54%	53	46%
15	Marque la imagen que usted considere que tiene un buen agarre del seno materno:	113	99%	1	1%
16	La succión del niño(a) es considerada adecuada, cuando las mamadas son:	68	60%	46	40%
17	Una succión adecuada también se puede observar cuando el niño presenta:	52	46%	62	54%

18	Cuando el niño no tiene un buen agarre, los senos de la madre pueden sufrir:	78	68%	36	32%
19	Se debe amamantar al niño(a) de cada: (rango de tiempo)	70	61%	44	39%
20	Se debe amamantar al niño(a) cada vez que: (situación o momento)	97	85%	17	15%